ALCALOÏDES DE L'ERGOT DE SEIGLE DOPAMINERGIQUES

(bromocriptine, cabergoline, lisuride)

+ ALCALOÏDES DE L'ERGOT DE SEIGLE VASOCONSTRICTEURS

	Risque de vasoconstriction et/ou de poussées hypertensives.	**Association DECONSEILLEE**

+ ANTIPARKINSONIENS ANTICHOLINERGIQUES

	Risque de majoration des troubles neuropsychiques.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique régulière, notamment en début d'association.

+ MACROLIDES (SAUF SPIRAMYCINE)

	Augmentation des concentrations plasmatiques du dopaminergique avec accroissement possible de son activité ou apparition de signes de surdosage.	**Association DECONSEILLEE**

+ SYMPATHOMIMÉTIQUES ALPHA (VOIES ORALE ET/OU NASALE)

	Risque de vasoconstriction et/ou de poussées hypertensives.	**Association DECONSEILLEE**

+ SYMPATHOMIMÉTIQUES INDIRECTS

	Risque de vasoconstriction et/ou de poussées hypertensives.	**Association DECONSEILLEE**

ALCALOÏDES DE L'ERGOT DE SEIGLE VASOCONSTRICTEURS

(dihydroergotamine, ergotamine, méthylergométrine)

+ ALCALOÏDES DE L'ERGOT DE SEIGLE DOPAMINERGIQUES

	Risque de vasoconstriction et/ou de poussées hypertensives.	**Association DECONSEILLEE**

+ INHIBITEURS PUISSANTS DU CYP3A4

	Risque de vasoconstriction coronaire ou des extrémités (ergotisme), ou de poussées hypertensives.	**CONTRE-INDICATION**

+ LÉTERMOVIR

	Risque de vasoconstriction coronaire ou des extrémités (ergotisme), ou de poussées hypertensives.	**CONTRE-INDICATION**

+ OMBITASVIR + PARITAPRÉVIR

	Augmentation des concentrations plasmatiques de l'alcaloïde de l'ergot de seigle vasoconstricteur par diminution de son métabolisme hépatique par la bithérapie.	**CONTRE-INDICATION**

+ SYMPATHOMIMÉTIQUES ALPHA (VOIES ORALE ET/OU NASALE)

	Risque de vasoconstriction et/ou de poussées hypertensives.	**Association DECONSEILLEE**

+ SYMPATHOMIMÉTIQUES INDIRECTS

	Risque de vasoconstriction et/ou de poussées hypertensives.	**Association DECONSEILLEE**

+ TRIPTANS

	Risque d'hypertension artérielle, de vasoconstriction artérielle coronaire.	**CONTRE-INDICATION** Respecter un délai de 6 à 24 heures, selon le triptan, entre la prise de celui-ci et celle de l'alcaloïde ergoté

ALCOOL (BOISSON OU EXCIPIENT)

(anpu

+ ACIDE NICOTINIQUE

	Risque de prurit, de rougeur et de chaleur, lié à une potentialisation de l'effet vasodilatateur.	**A prendre en compte**

+ ACITRETINE		
	Chez la femme en âge de procréer, risque de transformation de l'acitrétine en étrétinate, puissant tératogène dont la demi-vie très prolongée (120 jours) expose à un risque tératogène majeur en cas de grossesse, pendant le traitement et les 2 mois suivant son arrêt.	**CONTRE-INDICATION**
+ ANTABUSE (RÉACTION)		
	Effet antabuse (chaleur, rougeurs, vomissements, tachycardie).	**Association DECONSEILLEE** Eviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool. Tenir compte de l'élimination complète des médicaments en se référant à leur demi-vie avant la reprise de boissons alcoolisées ou du médicament contenant de l'alcool.
+ IMAO IRRÉVERSIBLES		
	Majoration des effets hypertenseurs et/ou hyperthermiques de la tyramine présente dans certaines boissons alcoolisées (chianti, certaines bières, etc).	**Association DECONSEILLEE** Eviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.
+ INSULINE		
	Augmentation de la réaction hypoglycémique (inhibition des réactions de compensation pouvant faciliter la survenue de coma hypoglycémique).	**Association DECONSEILLEE** Eviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.
+ MÉDICAMENTS SÉDATIFS		
	Majoration par l'alcool de l'effet sédatif de ces substances. L'altération de la vigilance peut rendre dangereuses la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.	**Association DECONSEILLEE** Eviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.
+ METFORMINE		
	Risque majoré d'acidose lactique lors d'intoxication alcoolique aiguë, particulièrement en cas de jeûne ou dénutrition, ou bien d'insuffisance hépatocellulaire.	**Association DECONSEILLEE** Eviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.
+ SULFAMIDES HYPOGLYCÉMIANTS		
	Effet antabuse, notamment pour glibenclamide, glipizide, tolbutamide. Augmentation de la réaction hypoglycémique (inhibition des réactions de compensation) pouvant faciliter la survenue de coma hypoglycémique.	**Association DECONSEILLEE** Eviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.

ALDESLEUKINE

+ PRODUITS DE CONTRASTE IODÉS		
	Majoration du risque de réaction aux produits de contraste en cas de traitement antérieur par interleukine 2 : éruption cutanée ou plus rarement hypotension, oligurie voire insuffisance rénale.	**A prendre en compte**

ALFENTANIL

Voir aussi : analgésiques morphiniques agonistes - analgésiques morphiniques de palier III - morphiniques - médicaments sédatifs - substrats à risque du CYP3A4

+ CIMETIDINE		
	Avec la cimétidine utilisée à des doses supérieures ou égales à 800 mg/j : augmentation de l'effet dépresseur respiratoire de l'analgésique opiacé par diminution de son métabolisme hépatique.	**Précaution d'emploi** Adapter la posologie de l'alfentanil en cas de traitement par la cimétidine.
+ DILTIAZEM		
	Augmentation de l'effet dépresseur respiratoire de l'analgésique opiacé par diminution de son métabolisme hépatique.	**Précaution d'emploi** Adapter la posologie de l'alfentanil en cas de traitement par le diltiazem.
+ ERYTHROMYCINE		
	Augmentation de l'effet dépresseur respiratoire de l'analgésique opiacé par diminution de son métabolisme hépatique.	**Précaution d'emploi** Adapter la posologie de l'alfentanil en cas de traitement par l'érythromycine.
+ FLUCONAZOLE		
	Augmentation de l'effet dépresseur respiratoire de l'analgésique opiacé par diminution de son métabolisme hépatique.	**Précaution d'emploi** Adapter la posologie de l'alfentanil en cas de traitement par le fluconazole.
+ INHIBITEURS PUISSANTS DU CYP3A4		
	Augmentation de l'effet dépresseur respiratoire de l'analgésique opiacé par diminution de son métabolisme hépatique.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et adaptation de la posologie de l'analgésique opiacé en cas de traitement par un inhibiteur puissant du CYP3A4.

ANTIARYTHMIQUES

De nombreux antiarythmiques sont dépresseurs de l'automatisme, de la conduction et de la contractilité cardiaques.
L'association d'antiarythmiques de classes différentes peut apporter un effet thérapeutique bénéfique, mais s'avère le plus souvent très délicate, nécessitant une surveillance clinique étroite et un contrôle de l'ECG. L'association d'antiarythmiques donnant des torsades de pointes (amiodarone, disopyramide, quinidiniques, sotalol…) est contre-indiquée.
L'association d'antiarythmiques de même classe est déconseillée, sauf cas exceptionnel, en raison du risque accru d'effets indésirables cardiaques.
L'association à des médicaments ayant des propriétés inotropes négatives, bradycardisantes et/ou ralentissant la conduction auriculo-ventriculaire est délicate et nécessite une surveillance clinique et un contrôle de l'ECG.

(amiodarone, cibenzoline, diltiazem, disopyramide, dronedarone, flecainide, hydroquinidine, lidocaine, mexiletine, propafenone, quinidine, sotalol, verapamil)

+ *AUTRES ANTIARYTHMIQUES*

	L'association de deux antiarythmiques est très délicate. Elle est dans la majorité des cas, contre-indiquée ou déconseillée.	**CI - ASDEC - APEC**

ANTIARYTHMIQUES CLASSE IA

(disopyramide, hydroquinidine, quinidine)

+ *ESMOLOL*

	Troubles de la contractilité, de l'automatisme et de la conduction (suppression des mécanismes sympathiques compensateurs).	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et ECG.

+ *INDUCTEURS ENZYMATIQUES PUISSANTS*

	Diminution des concentrations plasmatiques et de l'efficacité de l'antiarythmique, par augmentation de son métabolisme hépatique par l'inducteur.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique, ECG et contrôle des concentrations plasmatiques ; si besoin, adaptation de la posologie de l'antiarythmique pendant le traitement par l'inducteur et après son arrêt.

+ *RIFAMPICINE*

	Diminution des concentrations plasmatiques et de l'efficacité de l'antiarythmique (augmentation de son métabolisme hépatique).	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique, ECG et éventuellement de la concentration plasmatique de l'antiarythmique. Si besoin, adaptation de la posologie de l'antiarythmique pendant le traitement par la rifampicine et après son arrêt (risque de surdosage en antiarythmique).

ANTICHOLINESTÉRASIQUES

(voir aussi "bradycardisants")

+ MEDICAMENTS ATROPINIQUES
Il convient de prendre en compte le risque lié à l'association d'un médicament à action atropinique (imipraminiques, neuroleptiques phénothiaziniques, antispasmodiques, certains antihistaminiques H1…) chez un patient traité par anticholinestérasique. Outre la possible diminution de l'effet thérapeutique de ce dernier, l'interruption brutale du traitement atropinique expose au risque de dévoiler alors les effets muscariniques du parasympathomimétique avec symptomatologie de type « crise cholinergique », pouvant se manifester notamment par des convulsions.

+ AUTRES MEDICAMENTS ANTICHOLINESTERASIQUES
Il convient de prendre en compte l'association d'un médicament anticholinestérasique, donné dans une indication telle que la myasthénie ou l'atonie intestinale, à un autre anticholinestérasique donné dans la maladie d'Alzheimer, en raison d'un risque d'addition des effets indésirables de type cholinergique, notamment digestifs.

(ambenonium, donepezil, galantamine, neostigmine, pyridostigmine, rivastigmine)

+ *BÊTA-BLOQUANTS DANS L'INSUFFISANCE CARDIAQUE*

	Risque de bradycardie excessive (addition des effets bradycardisants).	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique régulière, notamment en début d'association.

+ *MÉDICAMENTS ATROPINIQUES*

	Risque de moindre efficacité de l'anticholinestérasique par antagonisme des récepteurs de l'acétylcholine par l'atropinique.	**A prendre en compte**

+ *PILOCARPINE*

	Risque d'addition des effets indésirables cholinergiques, notamment digestifs.	**A prendre en compte**

+ *SUXAMETHONIUM*

	Risque d'allongement du bloc moteur, majoré en cas de déficit partiel en pseudocholinestérase.	**A prendre en compte**

ANTICOAGULANTS ORAUX

(acenocoumarol, apixaban, dabigatran, édoxaban, fluindione, phenindione, rivaroxaban, warfarine)

+ *AUTRES ANTICOAGULANTS ORAUX*

	Risque de majoration des événements hémorragiques lors du relais d'un anticoagulant oral par un autre.	**A prendre en compte** Tenir compte de la demi-vie de l'anticoagulant oral et observer, le cas échéant, un délai de carence avant le début du traitement par l'autre. Penser à informer le patient.

+ ACIDE ACETYLSALICYLIQUE		
	Majoration du risque hémorragique, notamment en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal.	**CI - ASDEC - APEC** Contre-indication avec : - des doses anti-inflammatoires d'acide acétylsalicylique (>=1g par prise et/ou >=3g par jour) - des doses antalgiques ou antipyrétiques (>=500 mg par prise et/ou <3g par jour) et en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal Association déconseillée avec : - des doses antalgiques ou antipyrétiques (>=500 mg par prise et/ou <3g par jour) en l'absence d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal - des doses antiagrégantes (de 50 mg à 375 mg par jour) et en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal. Nécessité d'un contrôle le cas échéant, en particulier du temps de saignement. A prendre en compte avec : - des doses antiagrégantes (de 50 mg à 375 mg par jour)
+ ANTIAGRÉGANTS PLAQUETTAIRES		
	Augmentation du risque hémorragique.	**A prendre en compte**
+ ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS		
	Augmentation du risque hémorragique de l'anticoagulant oral (agression de la muqueuse gastroduodénale par les anti-inflammatoires non stéroïdiens).	**Association DECONSEILLEE** Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique étroite, voire biologique .
+ COBIMÉTINIB		
	Augmentation du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et le cas échéant, contrôle plus fréquent de l'INR.
+ DÉFIBROTIDE		
	Risque hémorragique accru.	**Association DECONSEILLEE**
+ GLUCOCORTICOÏDES (SAUF HYDROCORTISONE)		
	Glucocorticoïdes (voies générale et rectale) : impact éventuel de la corticothérapie sur le métabolisme de l'antivitamine K et sur celui des facteurs de la coagulation. Risque hémorragique propre à la corticothérapie (muqueuse digestive, fragilité vasculaire) à fortes doses ou en traitement prolongé supérieur à 10 jours.	**Précaution d'emploi** Lorsque l'association est justifiée, renforcer la surveillance : le cas échéant, avec les antivitamines K, contrôle biologique au 8e jour, puis tous les 15 jours pendant la corticothérapie et après son arrêt.
+ HÉPARINES		
	Augmentation du risque hémorragique.	**CI - PE** Les anticoagulants oraux d'action directe ne doivent pas être administrés conjointement à l'héparine. Lors du relais de l'un par l'autre, respecter l'intervalle entre les prises. Lors du relais héparine/antivitamine K (nécessitant plusieurs jours), renforcer la surveillance clinique et biologique.
+ IBRUTINIB		
	Augmentation du risque hémorragique.	**Association DECONSEILLEE** Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique et biologique étroite (pour les antivitamines K, contrôle plus fréquent de l'INR).
+ IMATINIB		
	Augmentation du risque hémorragique. Pour l'apixaban et le rivaroxaban, risque de diminution de leur métabolisme par l'imatinib, se surajoutant au risque pharmacodynamique.	**Association DECONSEILLEE** Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique et biologique étroite (pour les antivitamines K, contrôle plus fréquent de l'INR).
+ INHIBITEURS SÉLECTIFS DE LA RECAPTURE DE LA SÉROTONINE		
	Augmentation du risque hémorragique.	**A prendre en compte**
+ IPILIMUMAB		
	Augmentation du risque d'hémorragies digestives.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique étroite.
+ MÉDICAMENTS MIXTES ADRÉNERGIQUES-SÉROTONINERGIQUES		
	Augmentation du risque hémorragique.	**A prendre en compte**

+ THROMBOLYTIQUES		
	Augmentation du risque hémorragique.	**A prendre en compte**
+ TRAMADOL		
	Augmentation du risque hémorragique	**A prendre en compte** Surveillance particulièrement chez le sujet âgé.

ANTICONVULSIVANTS MÉTABOLISÉS

(acide valproique, ethosuximide, felbamate, fosphenytoine, lamotrigine, oxcarbazepine, pérampanel, phenobarbital, phenytoine, primidone, retigabine, tiagabine, topiramate, valpromide, zonisamide)

+ MILLEPERTUIS		
	Risque de diminution des concentrations plasmatiques et de l'efficacité de l'anticonvulsivant.	**CONTRE-INDICATION**

ANTICORPS MONOCLONAUX (HORS ANTI-TNF ALPHA)

(alemtuzumab, amivantamab, anifrolumab, atezolizumab, bélimumab, bimékizumab, blinatumomab, brentuximab, canakinumab, cétuximab, daratumumab, dénosumab, durvalumab, guselkumab, ibritumomab, inébilizumab, inotuzumab, ipilimumab, ixékizumab, natalizumab, nivolumab, obinutuzumab, ocrélizumab, ofatumumab, panitumumab, pembrolizumab, ramucirumab, rituximab, satralizumab, sécukinumab, siltuximab, spésolimab, tafasitamab, tézépelumab, tocilizumab, tralokinumab, ustékinumab, védolizumab)

+ VACCINS VIVANTS ATTÉNUÉS		
	Risque de maladie vaccinale généralisée, éventuellement mortelle.	**ASDEC - APEC** Association déconseillée avec : - anifrolumab, atézolizumab, bélimumab, bimékizumab, blinatumomab, canakinumab, durvalumab, guselkumab, inébilizumab, inotuzumab, ixékizumab, obinutuzumab, ocrélizumab, ofatumumab, rituximab, sacituzumab, spésolimab, tafasitamab, tézépelumab, tocilizumab, ustékinumab A prendre en compte avec : - alemtuzumab, amivantamab, brentuximab, cetuximab, daratumumab, dénosumab, ibritumomab, ipilimumab, natalizumab, nivolumab, panitumumab, pembrolizumab, ramucirumab, satralizumab, sécukinumab, siltuximab, tralokinumab, védolizumab

ANTIDÉPRESSEURS IMIPRAMINIQUES

(amitriptyline, amoxapine, clomipramine, dosulepine, doxepine, imipramine, maprotiline, trimipramine)

+ ADRÉNALINE (VOIE BUCCO-DENTAIRE OU SOUS-CUTANÉE)		
	Troubles du rythme ventriculaire graves par augmentation de l'excitabilité cardiaque.	**Précaution d'emploi** Limiter l'apport, par exemple : moins de 0,1 mg d'adrénaline en 10 minutes ou 0,3 mg en 1 heure chez l'adulte.
+ ANTIHYPERTENSEURS CENTRAUX		
	Risque d'inhibition de l'effet antihypertenseur par l'antidépresseur (antagonisme au niveau des récepteurs adrénergiques).	**Association DECONSEILLEE**
+ BÊTA-BLOQUANTS DANS L'INSUFFISANCE CARDIAQUE		
	Effet vasodilatateur et risque d'hypotension, notamment orthostatique (effet additif).	**A prendre en compte**
+ INHIBITEURS SÉLECTIFS DE LA RECAPTURE DE LA SÉROTONINE		
	Augmentation des concentrations plasmatiques de l'antidépresseur imipraminique avec risque de convulsions et augmentation des effets indésirables.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique accrue et, si nécessaire, adaptation posologique.
+ ORLISTAT		
	Risque d'échec thérapeutique en cas de traitement concomitant par orlistat.	**A prendre en compte**
+ SYMPATHOMIMÉTIQUES ALPHA ET BÊTA (VOIE IM ET IV)		
	Hypertension paroxystique avec possibilité de troubles du rythme (inhibition de l'entrée du sympathomimétique dans la fibre sympathique).	**Association DECONSEILLEE**

+ *ANAKINRA*

	Risque accru d'infections graves et de neutropénies.	**Association DECONSEILLEE**

+ *CANAKINUMAB*

	Risque de majoration des infections graves.	**Association DECONSEILLEE**

+ *VACCINS VIVANTS ATTÉNUÉS*

	Risque de maladie vaccinale généralisée éventuellement mortelle.	**CONTRE-INDICATION** Et pendant les 3 mois suivant l'arrêt du traitement.

ANTITUSSIFS MORPHINE-LIKE

(dextromethorphane, noscapine, pholcodine)

+ *ANALGÉSIQUES MORPHINIQUES AGONISTES*

	Risque majoré de dépression respiratoire, pouvant être fatale en cas de surdosage.	**A prendre en compte**

+ *METHADONE*

	Risque majoré de dépression respiratoire, pouvant être fatale en cas de surdosage.	**A prendre en compte**

ANTITUSSIFS MORPHINIQUES VRAIS

(codeine, ethylmorphine)

+ *ANALGÉSIQUES MORPHINIQUES AGONISTES*

	Risque majoré de dépression respiratoire, pouvant être fatale en cas de surdosage.	**A prendre en compte**

+ *METHADONE*

	Risque majoré de dépression respiratoire, pouvant être fatale en cas de surdosage.	**A prendre en compte**

+ *MORPHINIQUES AGONISTES-ANTAGONISTES*

	Diminution de l'effet antalgique ou antitussif du morphinique, par blocage compétitif des récepteurs, avec risque d'apparition d'un syndrome de sevrage.	**Association DECONSEILLEE**

ANTIVITAMINES K

ANTI-INFECTIEUX ET HEMOSTASE
De nombreux cas d'augmentation de l'activité des antivitamines K ont été rapportés chez des patients recevant des antibiotiques. Le contexte infectieux ou inflammatoire marqué, l'âge et l'état général du patient apparaissent comme des facteurs de risque. Dans ces circonstances, il apparaît difficile de faire la part entre la pathologie infectieuse et son traitement dans la survenue du déséquilibre de l'INR. Cependant, certaines classes d'antibiotiques sont davantage impliquées : il s'agit notamment des fluoroquinolones, des macrolides, des cyclines, du cotrimoxazole et de certaines céphalosporines, qui imposent, dans ces conditions, de renforcer la surveillance de l'INR. Certaines céphalosporines (céfamandole, ceftriaxone, céfazoline), la clindamycine, semblent interagir au niveau de l'hémostase avec apparition d'anticorps anti facteur V. Enfin, la tigécycline et le danazol possèdent une action fibrinolytique propre.

AVK et INR
Chez un patient traité par antivitamines K, il convient de contrôler l'INR à chaque initiation ou suppression d'un ou plusieurs médicaments. La modification soudaine des habitudes alimentaires doit être également prise en compte et la régularité est préconisée pour le maintien à l'équilibre de l'INR. Les aliments riches en vitamine K sont essentiellement représentés par les choux, épinards, brocolis, certaines salades.

(acenocoumarol, fluindione, warfarine)

+ *ALLOPURINOL*

	Augmentation du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par l'allopurinol et 8 jours après son arrêt.

+ *AMIODARONE*

	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par l'amiodarone et jusqu'à 4 semaines après son arrêt.

+ *ANDROGÈNES*

	Augmentation du risque hémorragique par effet direct sur la coagulation et/ou les systèmes fibrinolytiques.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par l'androgène et après son arrêt.

+ ANTIPURINES		
	Augmentation du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K à la mise en route du traitement par l'immunomodulateur et après son arrêt.
+ APREPITANT		
	Risque de diminution de l'effet de l'antivitamine K par augmentation de son métabolisme hépatique par l'aprépitant.	**A prendre en compte**
+ BOSENTAN		
	Diminution de l'effet de l'antivitamine K par augmentation de son métabolisme hépatique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K.
+ CEFAMANDOLE		
	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par la céphalosporine et après son arrêt.
+ CEFAZOLINE		
	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par la céphalosporine et après son arrêt.
+ CEFTRIAXONE		
	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par la céphalosporine et après son arrêt.
+ CIMETIDINE		
	Avec la cimétidine utilisée à des doses supérieures ou égales à 800 mg/j : augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique (diminution de son métabolisme hépatique).	**A prendre en compte**
+ CLINDAMYCINE		
	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par clindamycine et après son arrêt.
+ COLCHICINE		
	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par la colchicine et 8 jours après son arrêt.
+ CYCLINES		
	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique (pour la tigécycline, effet direct sur la coagulation et/ou les systèmes fibrinolytiques).	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par la cycline et après son arrêt.
+ CYTOTOXIQUES		
	Augmentation du risque thrombotique et hémorragique au cours des affections tumorales. De surcroit, possible interaction entre les AVK et la chimiothérapie.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR.
+ DANAZOL		
	Augmentation du risque hémorragique par effet direct sur la coagulation et/ou les systèmes fibrinolytiques.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par le danazol et après son arrêt.
+ DEFERASIROX		
	Majoration du risque ulcérogène et hémorragique digestif.	**A prendre en compte**
+ DISULFIRAME		
	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par le disulfirame et 8 jours après son arrêt.

+ ECONAZOLE		
	Quelle que soit la voie d'administration de l'éconazole : augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par éconazole et après son arrêt.
+ EFAVIRENZ		
	Diminution de l'effet de l'antivitamine K par augmentation de son métabolisme hépatique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K.
+ FIBRATES		
	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par le fibrate et 8 jours après son arrêt.
+ FLUCONAZOLE		
	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par le fluconazole et 8 jours après son arrêt.
+ FLUOROQUINOLONES		
	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par la fluoroquinolone et après son arrêt.
+ FLUOROURACILE (ET, PAR EXTRAPOLATION, AUTRES FLUOROPYRIMIDINES)		
	Augmentation importante de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Association DECONSEILLEE** Si elle ne peut être évitée, contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par le cytotoxique et 8 jours après son arrêt.
+ GLUCOSAMINE		
	Augmentation du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adapation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K.
+ INDUCTEURS ENZYMATIQUES PUISSANTS		
	Diminution (ou, rarement, augmentation avec la phénytoïne) de l'effet de l'antivitamine K par augmentation de son métabolisme hépatique par l'anticonvulsivant inducteur.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par l'anticonvulsivant inducteur et 8 jours après son arrêt.
+ INHIBITEURS DE L'HMG-COA RÉDUCTASE (STATINES)		
	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K.
+ INHIBITEURS DE PROTÉASES BOOSTÉS PAR RITONAVIR		
	Variation de l'effet de l'antivitamine K, le plus souvent dans le sens d'une diminution.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant la durée du traitement.
+ LEVOCARNITINE		
	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par la lévocarnitine et 8 jours après son arrêt.
+ MACROLIDES (SAUF SPIRAMYCINE)		
	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par le macrolide et après son arrêt.
+ METHYLPREDNISOLONE		
	Pour des doses de 0,5 à 1g de méthylprednisolone administrées en bolus : augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle de l'INR 2 à 4 jours après le bolus de méthylprednisolone ou en présence de tous signes hémorragiques.
+ MICONAZOLE		
	Hémorragies imprévisibles, éventuellement graves.	**CONTRE-INDICATION**

+ MILLEPERTUIS		
	Diminution des concentrations plasmatiques de l'antivitamine K, en raison de son effet inducteur enzymatique, avec risque de baisse d'efficacité voire d'annulation de l'effet dont les conséquences peuvent être éventuellement graves (évènement thrombotique).	**CONTRE-INDICATION** En cas d'association fortuite, ne pas interrompre brutalement la prise de millepertuis mais contrôler l'INR avant puis après l'arrêt du millepertuis.
+ NEVIRAPINE		
	Diminution de l'effet de l'antivitamine K par augmentation de son métabolisme hépatique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K.
+ NOSCAPINE		
	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Association DECONSEILLEE**
+ ORLISTAT		
	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par l'orlistat et après son arrêt.
+ PARACETAMOL		
	Risque d'augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique en cas de prise de paracétamol aux doses maximales (4 g/j) pendant au moins 4 jours.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par le paracétamol et après son arrêt.
+ PENTOXIFYLLINE		
	Augmentation du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par la pentoxifylline et 8 jours après son arrêt.
+ PRISTINAMYCINE		
	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par la pristinamycine et après son arrêt.
+ PROGUANIL		
	Risque d'augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par le proguanil et après son arrêt.
+ RIFAMPICINE		
	Diminution de l'effet de l'antivitamine K par augmentation de son métabolisme hépatique par la rifampicine.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par la rifampicine et 8 jours après son arrêt.
+ ROPINIROLE		
	Augmentation du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par ropinirole et après son arrêt.
+ SULFAMETHOXAZOLE		
	Augmentation importante de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Association DECONSEILLEE** Si l'association ne peut être évitée, contrôle plus fréquent de l'INR et adaptation de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par cotrimoxazole et après son arrêt.
+ TAMOXIFENE		
	Risque d'augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K.
+ TIBOLONE		
	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par la tibolone et après son arrêt.
+ VORICONAZOLE		
	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique par diminution de son métabolisme hépatique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par voriconazole et 8 jours après son arrêt.

APALUTAMIDE

Voir aussi : inducteurs enzymatiques - inducteurs enzymatiques puissants - médicaments à l'origine d'un hypogonadisme masculin

+ ATORVASTATINE

	Risque de diminution très importante des concentrations de l'atorvastatine, et perte d'efficacité, par augmentation de son métabolisme hépatique par l'apalutamide.	**Association DECONSEILLEE**

+ CABAZITAXEL

	Risque de diminution très importante des concentrations du cabazitaxel, et perte d'efficacité, par augmentation de son métabolisme hépatique par l'apalutamide.	**Association DECONSEILLEE**

+ DOCETAXEL

	Risque de diminution très importante des concentrations du docétaxel, et perte d'efficacité, par augmentation de son métabolisme hépatique par l'apalutamide.	**Association DECONSEILLEE**

+ IMMUNOSUPPRESSEURS

	Risque de diminution très importante des concentrations des immunosuppresseurs, et perte d'efficacité, par augmentation de leur métabolisme hépatique par l'apalutamide.	**Association DECONSEILLEE**

+ METHADONE

	Risque de diminution très importante des concentrations de la méthadone, et perte d'efficacité, par augmentation de son métabolisme hépatique par l'apalutamide.	**Association DECONSEILLEE**

+ OLAPARIB

	Risque de diminution très importante des concentrations de l'olaparib, et perte d'efficacité, par augmentation de son métabolisme hépatique par l'apalutamide.	**Association DECONSEILLEE**

+ OMEPRAZOLE

	Risque de diminution très importante des concentrations de l'oméprazole, et perte d'efficacité, par augmentation de son métabolisme hépatique par l'apalutamide.	**Association DECONSEILLEE**

+ PIMOZIDE

	Risque de diminution très importante des concentrations du pimozide, et perte d'efficacité, par augmentation de son métabolisme hépatique par l'apalutamide.	**Association DECONSEILLEE**

+ SIMVASTATINE

	Risque de diminution très importante des concentrations de la simvastatine, et perte d'efficacité, par augmentation de son métabolisme hépatique par l'apalutamide.	**Association DECONSEILLEE**

APIXABAN

Voir aussi : anticoagulants oraux - substrats à risque du CYP3A4

+ FLUCONAZOLE

	Augmentation des concentrations plasmatiques de l'apixaban par le fluconazole, avec majoration du risque de saignement.	**Association DECONSEILLEE**

+ INDUCTEURS ENZYMATIQUES PUISSANTS

	Diminution des concentrations plasmatiques de l'apixaban par l'inducteur enzymatique, avec risque de réduction de l'effet thérapeutique.	**Association DECONSEILLEE**

+ INHIBITEURS PUISSANTS DU CYP3A4

	Augmentation des concentrations plasmatiques de l'apixaban par l'inhibiteur, avec majoration du risque de saignement.	**Association DECONSEILLEE**

+ RIFAMPICINE

	Diminution des concentrations plasmatiques de l'apixaban par la rifampicine, avec risque de diminution de l'effet thérapeutique.	**Association DECONSEILLEE**

+ *POSACONAZOLE*		
	Augmentation des concentrations plasmatiques de l'atazanavir et du risque d'hyperbilirubinémie.	**A prendre en compte**
+ *TENOFOVIR DISOPROXIL*		
	Diminution d'environ un tiers de l'exposition à l'atazanavir chez le patient en cas d'association au ténofovir, comparativement au sujet sain recevant la même association.	**A prendre en compte** Ne pas administrer l'atazanavir avec le ténofovir sans ritonavir.

ATORVASTATINE

Voir aussi : inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase (statines) - médicaments à l'origine d'atteintes musculaires - substrats à risque du CYP3A4

+ *APALUTAMIDE*		
	Risque de diminution très importante des concentrations de l'atorvastatine, et perte d'efficacité, par augmentation de son métabolisme hépatique par l'apalutamide.	**Association DECONSEILLEE**
+ *AZITHROMYCINE*		
	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse, par diminution du métabolisme hépatique de l'hypocholestérolémiant.	**Précaution d'emploi** Utiliser des doses plus faibles d'hypocholestérolémiant ou une autre statine non concernée par ce type d'interaction.
+ *CICLOSPORINE*		
	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse (diminution du métabolisme de l'hypocholestérolémiant).	**Précaution d'emploi** Ne pas dépasser la posologie de 10mg/jour d'atorvastatine. Si l'objectif thérapeutique n'est pas atteint à cette posologie, utiliser une autre statine non concernée par ce type d'interaction.
+ *CLARITHROMYCINE*		
	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse, par diminution du métabolisme hépatique de l'hypocholesterolémiant.	**Précaution d'emploi** Utiliser des doses plus faibles d'hypocholestérolémiant. Si l'objectif thérapeutique n'est pas atteint, utiliser une autre statine non concernée par ce type d'interaction.
+ *DILTIAZEM*		
	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse, par diminution du métabolisme hépatique de l'hypocholestérolémiant.	**Précaution d'emploi** Utiliser des doses plus faibles d'hypocholestérolémiant ou une autre statine non concernée par ce type d'interaction.
+ *ERYTHROMYCINE*		
	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse, par diminution du métabolisme hépatique de l'hypocholesterolémiant.	**Précaution d'emploi** Utiliser des doses plus faibles d'hypocholestérolémiant. Si l'objectif thérapeutique n'est pas atteint, utiliser une autre statine non concernée par ce type d'interaction.
+ *FLUCONAZOLE*		
	Risque majoré d'effets indésirables concentration-dépendants à type de rhabdomyolyse (diminution du métabolisme hépatique de la statine).	**Précaution d'emploi** Utiliser des doses plus faibles de l'hypocholestérolémiant. Si l'objectif thérapeutique n'est pas atteint, utiliser une autre statine non concernée par ce type d'interaction.
+ *GLÉCAPRÉVIR + PIBRENTASVIR*		
	Augmentation importante des concentrations plasmatiques d'atorvastatine par la bithérapie, avec risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyses.	**CONTRE-INDICATION**
+ *INHIBITEURS DE PROTÉASES BOOSTÉS PAR RITONAVIR*		
	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse (diminution du métabolisme hépatique de l'atorvastatine).	**Association DECONSEILLEE** Utiliser des doses plus faibles d'atorvastatine. Si l'objectif thérapeutique n'est pas atteint, utiliser une autre statine non concernée par ce type d'interaction.
+ *ITRACONAZOLE*		
	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse (diminution du métabolisme hépatique de l'atorvastatine).	**CONTRE-INDICATION**
+ *KETOCONAZOLE*		
	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse (diminution du métabolisme hépatique de l'atorvastatine).	**CONTRE-INDICATION**
+ *OMBITASVIR + PARITAPRÉVIR*		
	Augmentation des concentrations plasmatiques de l'atorvastatine par diminution de son métabolisme hépatique par la bithérapie.	**CONTRE-INDICATION**

+ PAMPLEMOUSSE (JUS ET FRUIT)		
	Augmentation des concentrations plasmatiques de l'hypolipémiant, avec risque de survenue d'effets indésirables, notamment musculaires.	**A prendre en compte**
+ PONATINIB		
	Risque d'augmentation des concentrations plasmatiques de l'atrovastatine par augmentation de son absorption intestinale par le ponatinib.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique étroite pendant l'association.
+ POSACONAZOLE		
	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse (diminution du métabolisme hépatique de l'inhibiteur de l'HMG-CoA reductase).	**CONTRE-INDICATION**
+ RANOLAZINE		
	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse par inhibition du métabolisme de l'atorvastatine par la ranolazine.	**Précaution d'emploi** Utiliser des doses plus faibles d'hypocholestérolémiant ou une autre statine non concernée par ce type d'interaction.
+ RIFAMPICINE		
	Diminution très importante des concentrations plasmatiques d'atorvastatine, par augmentation de son métabolisme hépatique par la rifampicine.	**Association DECONSEILLEE**
+ ROXITHROMYCINE		
	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse.	**Précaution d'emploi** Utiliser des doses plus faibles d'hypocholestérolémiant.
+ STIRIPENTOL		
	Risque majoré d'effets indésirables (dose-dépendants) à type de rhabdomyolyse (diminution du métabolisme hépatique de l'hypocholestérolémiant).	**CONTRE-INDICATION**
+ TELITHROMYCINE		
	Risque majoré d'effets indésirables (dose-dépendants) à type de rhabdomyolyse (diminution du métabolisme hépatique de l'hypocholestérolémiant).	**CONTRE-INDICATION**
+ VERAPAMIL		
	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse, par diminution du métabolisme hépatique de l'hypocholestérolémiant.	**Précaution d'emploi** Utiliser des doses plus faibles d'hypocholestérolémiant. Si l'objectif thérapeutique n'est pas atteint, utiliser une autre statine non concernée par ce type d'interaction.

ATOVAQUONE

+ EFAVIRENZ		
	Diminution des concentrations plasmatiques d'atovaquone par l'inducteur enzymatique.	**Association DECONSEILLEE**
+ INHIBITEURS DE PROTÉASES BOOSTÉS PAR RITONAVIR		
	Diminution, éventuellement très importante, des concentrations plasmatiques de l'atovaquone par augmentation de son métabolisme.	**Association DECONSEILLEE**
+ RIFABUTINE		
	Diminution modérée des concentrations plasmatiques d'atovaquone par l'inducteur enzymatique.	**A prendre en compte**
+ RIFAMPICINE		
	Diminution des concentrations plasmatiques d'atovaquone par l'inducteur enzymatique.	**Association DECONSEILLEE**

AVANAFIL

Voir aussi : inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 - médicaments à l'origine d'une hypotension orthostatique

+ PAMPLEMOUSSE (JUS ET FRUIT)		
	Augmentation des concentrations plasmatiques de l'avanafil, avec risque d'hypotension.	**Association DECONSEILLEE**

+ *SUBSTANCES SUSCEPTIBLES DE DONNER DES TORSADES DE POINTES*

	Risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointes.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et électrocardiographique.

+ *SULFAMIDES HYPOGLYCÉMIANTS*

	Tous les bêta-bloquants peuvent masquer certains symptômes de l'hypoglycémie : palpitations et tachycardie.	**Précaution d'emploi** Prévenir le malade et renforcer, surtout au début du traitement, l'autosurveillance sanguine.

+ *VERAPAMIL*

	Effet inotrope négatif avec risque de décompensation de l'insuffisance cardiaque, troubles de l'automatisme (bradycardie, arrêt sinusal) et troubles de la conduction sino-auriculaire et auriculo-ventriculaire.	**Association DECONSEILLEE**

BÊTA-BLOQUANTS NON CARDIO-SÉLECTIFS (Y COMPRIS COLLYRES)

(carteolol, carvedilol, labetalol, nadolol, pindolol, propranolol, sotalol, tertatolol, timolol)

+ *BÊTA-2 MIMÉTIQUES*

	Risque de moindre efficacité réciproque par antagonisme pharmacodynamique.	**A prendre en compte**

BICTÉGRAVIR

Voir aussi : inhibiteurs d'intégrase - substances à absorption réduite par les topiques gastro-intestinaux, antiacides et adsorbants

+ *ATAZANAVIR*

	Quadruplement des concentrations de bictégravir.	**Association DECONSEILLEE**

+ *FER*

	Diminution de près des deux tiers de l'absorption du bictégravir en cas d'ingestion simultanée ou à jeun.	**Précaution d'emploi** Prendre le bictégravir au moins 2 heures avant les sels de fer, ou en même temps qu'un repas.

+ *INDUCTEURS ENZYMATIQUES*

	Risque de perte d'efficacité par diminution, éventuellement importante, des concentrations de bictégravir.	**CI - ASDEC** Contre-indication : - avec la rifampicine Association déconseillée : - avec les autres inducteurs enzymatiques

+ *MILLEPERTUIS*

	Diminution très importante des concentrations de bictégravir, avec risque de perte d'efficacité.	**CONTRE-INDICATION**

+ *RIFAMPICINE*

	Diminution très importante des concentrations de bictégravir, avec risque de perte d'efficacité.	**CONTRE-INDICATION**

BISPHOSPHONATES

(acide alendronique, acide clodronique, acide etidronique, acide ibandronique, acide oxidronique, acide pamidronique, acide risedronique, acide tiludronique, acide zoledronique)

+ *CALCIUM*

	Pour les sels de calcium administrés par voie orale : diminution de l'absorption digestive des bisphosphonates.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de calcium et antiacides à distance des bisphosphonates (de 30 minutes au minimum à plus de 2 heures, si possible, selon le bisphosphonate).

+ *FER*

	Pour les sels de fer administrés par voie orale : diminution de l'absorption digestive des bisphosphonates.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de fer à distance des bisphosphonates (de 30 minutes au minimum à plus de 2 heures, si possible, selon le bisphosphonate).

BLEOMYCINE

Voir aussi : cytotoxiques

+ *BRENTUXIMAB*

	Risque de majoration de la toxicité pulmonaire.	**CONTRE-INDICATION**

CABOTEGRAVIR

Voir aussi : inhibiteurs d'intégrase

+ INDUCTEURS ENZYMATIQUES

	Diminution importante des concentrations de cabotégravir avec la rifampicine, avec risque de réduction de la réponse virologique.	**CI - APEC** Contre-indication : - avec la rifampicine, la carbamazépine, l'oxcarbazépine, la phénytoïne, le phénobarbital A prendre en compte : - avec les autres inducteurs

CAFEINE

+ CIPROFLOXACINE

	Augmentation des concentrations plasmatiques de caféine, par diminution de son métabolisme hépatique.	**A prendre en compte**

+ DIPYRIDAMOLE

	Avec le dipyridamole par voie injectable : réduction de l'effet vasodilatateur du dipyridamole par la caféine.	**Précaution d'emploi** Interrompre un traitement à base de caféine au moins 5 jours avant une imagerie myocardique avec le dipyridamole et éviter la consommation de café, thé, chocolat ou cola dans les 24 heures qui précèdent le test.

+ ENOXACINE

	Augmentation des concentrations plasmatiques de caféine, pouvant entraîner excitations et hallucinations, par diminution de son métabolisme hépatique.	**Association DECONSEILLEE**

+ LITHIUM

	En cas d'arrêt brutal de la consommation de café ou de médicaments contenant de la caféine, risque d'augmentation de la lithémie.	**A prendre en compte**

+ MEXILETINE

	Augmentation des concentrations plasmatiques de caféine, par inhibition de son métabolisme hépatique par la méxilétine.	**A prendre en compte**

+ NORFLOXACINE

	Augmentation des concentrations plasmatiques de caféine, par diminution du métabolisme hépatique de la caféine.	**A prendre en compte**

+ STIRIPENTOL

	Augmentation possible des concentrations plasmatiques de la caféine, avec risque de surdosage, par inhibition de son métabolisme hépatique.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et adaptation éventuelle de la posologie de caféine.

CALCITONINE

+ LITHIUM

	Risque de baisse de l'efficacité du lithium par augmentation de son élimination rénale par la calcitonine.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique régulière, notamment en début d'association.

CALCIUM

+ BISPHOSPHONATES

	Pour les sels de calcium administrés par voie orale : diminution de l'absorption digestive des bisphosphonates.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de calcium et antiacides à distance des bisphosphonates (de 30 minutes au minimum à plus de 2 heures, si possible, selon le bisphosphonate).

+ CIPROFLOXACINE

	Diminution de l'absorption digestive de la ciprofloxacine.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de calcium à distance de la ciprofloxacine (plus de 2 heures, si possible).

+ CYCLINES

	Diminution de l'absorption digestive des cyclines.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de calcium à distance des cyclines (plus de deux heures, si possible).

+ DIGOXINE		
	Risque de troubles du rythme graves, voire mortels avec les sels de calcium administrés par voie IV.	**CI - PE** Contre-indication : - avec les sels de calcium IV, hormis supplémentation parentérale. Précaution d'emploi : - avec les sels de calcium par voie orale. Surveillance clinique et, s'il y a lieu, contrôle de l'ECG et de la calcémie.
+ DIURÉTIQUES THIAZIDIQUES ET APPARENTÉS		
	Risque d'hypercalcémie par diminution de l'élimination urinaire du calcium.	**A prendre en compte**
+ ESTRAMUSTINE		
	Diminution de l'absorption digestive de l'estramustine.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de calcium à distance de l'estramustine (plus de 2 heures, si possible).
+ FER		
	Avec les sels de fer par voie orale : diminution de l'absorption digestive des sels de fer.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de fer à distance des repas et en l'absence de calcium.
+ HORMONES THYROÏDIENNES		
	Diminution de l'absorption digestive des hormones thyroïdiennes.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de calcium à distance des hormones thyroïdiennes (plus de 2 heures, si possible).
+ INHIBITEURS D'INTÉGRASE		
	Diminution de l'absorption digestive des inhibiteurs d'intégrase.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de calcium à distance de l'antirétroviral (plus de 2 heures, si possible).
+ NORFLOXACINE		
	Diminution de l'absorption digestive de la norfloxacine.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de calcium à distance de la norfloxacine (plus de 2 heures, si possible).
+ ROXADUSTAT		
	La prise de cation divalent peut diminuer l'absorption intestinale et, potentiellement, l'efficacité du roxadustat pris simultanément.	**Précaution d'emploi** Prendre le roxadustat à distance des sels de calcium (plus de 1 heure, si possible).
+ STRONTIUM		
	Avec les sels de calcium administrés par voie orale : diminution de l'absorption digestive du strontium.	**Précaution d'emploi** Prendre le strontium à distance des sels de calcium (plus de deux heures, si possible).
+ ZINC		
	Diminution de l'absorption digestive du zinc par le calcium.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de calcium à distance du zinc (plus de 2 heures si possible).

CANAKINUMAB

Voir aussi : anticorps monoclonaux (hors anti-TNF alpha)

+ ANTI-TNF ALPHA		
	Risque de majoration des infections graves.	**Association DECONSEILLEE**

CANNABIDIOL

+ INDUCTEURS ENZYMATIQUES PUISSANTS		
	Diminution des concentrations plasmatiques de cannabidiol avec risque de perte d'efficacité.	**Association DECONSEILLEE**
+ MILLEPERTUIS		
	Diminution des concentrations plasmatiques de cannabidiol avec risque de perte d'efficacité.	**CONTRE-INDICATION**

+ BOSENTAN		
	Risque de diminution de l'efficacité de la cyprotérone.	**Précaution d'emploi** Dans ses indications comme anti-androgène, surveillance clinique et si possible adaptation de la posologie de la cyprotérone pendant l'administration avec le bosentan et après son arrêt. Dans son utilisation comme contraceptif hormonal, utiliser une méthode de contraception fiable, additionnelle ou alternative pendant la durée de l'association.
+ INDUCTEURS ENZYMATIQUES		
	Risque de diminution de l'efficacité de la cyprotérone.	**ASDEC - PE** Association déconseillée: - dans son utilisation comme contraceptif hormonal: utiliser de préférence une autre méthode de contraception en particulier de type mécanique, pendant la durée de l'association et un cycle suivant. Précaution d'emploi - dans ses indications comme anti-androgène: surveillance clinique et adaptation éventuelle de la posologie de la cyprotérone pendant l'association et après son arrêt.
+ INHIBITEURS DE PROTÉASES BOOSTÉS PAR RITONAVIR		
	Risque de diminution de l'efficacité de la cyprotérone.	**ASDEC - PE** Association déconseillée - dans son utilisation comme contraceptif hormonal: utiliser de préférence une autre méthode de contraception en particulier de type mécanique, pendant la durée de l'association et un cycle suivant. Précaution d'emploi - dans ses indications comme anti-androgène: surveillance clinique et adaptation éventuelle de la posologie de la cyprotérone pendant l'association et après son arrêt.
+ MILLEPERTUIS		
	Risque de diminution de l'efficacité de la cyprotérone, par augmentation de son métabolisme hépatique par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**
+ PÉRAMPANEL		
	Pour des doses de pérampanel > ou = à 12 mg/jour, risque de diminution de l'efficacité de la cyprotérone.	**Association DECONSEILLEE** Dans son utilisation comme contraceptif hormonal: utiliser de préférence une autre méthode de contraception en particulier de type mécanique, pendant la durée de l'association et un cycle suivant.
+ ULIPRISTAL		
	Dans l'indication contraception d'urgence de l'ulipristal : Antagonisme des effets de l'ulipristal en cas de reprise d'un contraceptif hormonal moins de 5 jours après la prise de la contraception d'urgence. Dans l'indication fibrome de l'ulipristal : Antagonisme réciproque des effets de l'ulipristal et du progestatif, avec risque d'inefficacité.	**ASDEC - APEC** Association déconseillée Dans l'utilisation à visée contraceptive de la cyprotérone - Dans l'indication contraception d'urgence de l'ulipristal Dans le cas où la (re)prise d'une contraception hormonale est envisagée, utiliser une contraception additionnelle de type mécanique pendant les 12 jours qui suivent la (dernière) prise de l'ulipristal (au cas où il y en aurait eu plus d'une). - Dans l'indication fibrome de l'ulipristal : Dans le cas où la (re)prise d'une contraception hormonale est envisagée, utiliser une contraception de type mécanique pendant les 7 premiers jours de la contraception hormonale. Association à prendre en compte Lorsque la cyprotérone n'est pas à visée contraceptive.

CYTOTOXIQUES

(altretamine, amsacrine, asparaginase, azacitidine, azathioprine, bendamustine, bleomycine, bortezomib, busulfan, cabazitaxel, capecitabine, carboplatine, carmustine, chlorambucil, cisplatine, cladribine, clofarabine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine, daunorubicine, décitabine, dexrazoxane, docetaxel, doxorubicine, epirubicine, éribuline, estramustine, etoposide, fludarabine, fluorouracile, fotemustine, gemcitabine, giméracil, hydroxycarbamide, idarubicine, ifosfamide, irinotecan, lomustine, melphalan, mercaptopurine, methotrexate, mitomycine c, mitoxantrone, nélarabine, otéracil, oxaliplatine, paclitaxel, pemetrexed, pentostatine, pipobroman, pixantrone, procarbazine, raltitrexed, streptozocine, tegafur, temozolomide, thiotepa, tioguanine, topotecane, vinblastine, vincristine, vindesine, vinflunine, vinorelbine)

+ ANTIVITAMINES K		
	Augmentation du risque thrombotique et hémorragique au cours des affections tumorales. De surcroit, possible interaction entre les AVK et la chimiothérapie.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR.
+ FLUCYTOSINE		
	Risque de majoration de la toxicité hématologique	**A prendre en compte**

+ *IMMUNOSUPPRESSEURS*		
	Immunodépression excessive avec risque de syndrome lympho-prolifératif.	**A prendre en compte**
+ *OLAPARIB*		
	Risque de majoration de l'effet myélosuppresseur du cytotoxique	**Association DECONSEILLEE**
+ *PHÉNYTOÏNE (ET, PAR EXTRAPOLATION, FOSPHÉNYTOÏNE)*		
	Risque de survenue de convulsions par diminution de l'absorption digestive de la seule phénytoïne par le cytotoxique, ou bien risque de majoration de la toxicité ou de perte d'efficacité du cytotoxique par augmentation de son métabolisme hépatique par la phénytoïne ou la fosphénytoïne.	**Association DECONSEILLEE**
+ *VACCINS VIVANTS ATTÉNUÉS*		
	Risque de maladie vaccinale généralisée éventuellement mortelle.	**CONTRE-INDICATION** - Et pendant les 6 mois suivant l'arrêt de la chimiothérapie. - Et, à l'exception de l'hydroxycarbamide dans son indication chez le patient drépanocytaire.

DABIGATRAN

Voir aussi : anticoagulants oraux

+ *AMIODARONE*		
	Augmentation des concentrations plasmatiques de dabigatran, avec majoration du risque de saignement.	**Précaution d'emploi** Dans l'indication post-chirurgicale : surveillance clinique et adaptation de la posologie du dabigatran si nécessaire, sans excéder 150 mg/j.
+ *CICLOSPORINE*		
	Augmentation de plus du double des concentrations plasmatiques de dabigatran, avec majoration du risque de saignement.	**CONTRE-INDICATION**
+ *DRONEDARONE*		
	Doublement des concentrations plasmatiques de dabigatran, avec majoration du risque de saignement.	**CONTRE-INDICATION**
+ *GLÉCAPRÉVIR + PIBRENTASVIR*		
	Doublement des concentrations plasmatiques de dabigatran, avec majoration du risque de saignements.	**CONTRE-INDICATION**
+ *INDUCTEURS ENZYMATIQUES PUISSANTS*		
	Diminution des concentrations plasmatiques de dabigatran, avec risque de diminution de l'effet thérapeutique.	**Association DECONSEILLEE**
+ *ITRACONAZOLE*		
	Augmentation de plus du double des concentrations plasmatiques de dabigatran, avec majoration du risque de saignement.	**CONTRE-INDICATION**
+ *KETOCONAZOLE*		
	Augmentation de plus du double des concentrations plasmatiques de dabigatran, avec majoration du risque de saignement.	**CONTRE-INDICATION**
+ *PONATINIB*		
	Risque d'augmentation des concentrations plasmatiques du dabigatran par augmentation de son absorption intestinale par le ponatinib.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique étroite pendant l'association.
+ *QUINIDINE*		
	Augmentation des concentrations plasmatiques de dabigatran, avec majoration du risque de saignement.	**Précaution d'emploi** Dans l'indication post-chirurgicale : surveillance clinique et adaptation de la posologie du dabigatran à 150 mg/j en une prise.
+ *RIFAMPICINE*		
	Diminution des concentrations plasmatiques de dabigatran, avec risque de diminution de l'effet thérapeutique.	**Association DECONSEILLEE**

FENTANYL

Voir aussi : analgésiques morphiniques agonistes - analgésiques morphiniques de palier III - morphiniques - médicaments sédatifs

+ INDUCTEURS ENZYMATIQUES PUISSANTS

	Diminution des concentrations plasmatiques de fentanyl par augmentation de son métabolisme hépatique par l'inducteur.	**Association DECONSEILLEE** Préférer un autre morphinique.

+ INHIBITEURS PUISSANTS DU CYP3A4

	Risque d'augmentation de l'effet dépresseur respiratoire de l'analgésique opiacé par légère diminution de son métabolisme hépatique.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et adaptation éventuelle de la posologie de l'analgésique opiacé en cas de traitement par un inhibiteur puissant du CYP3A4.

+ RIFAMPICINE

	Diminution des concentrations plasmatiques de fentanyl par augmentation de son métabolisme hépatique par la rifampicine.	**Association DECONSEILLEE** Préférer un autre morphinique.

FER

Voir aussi : substances à absorption réduite par les topiques gastro-intestinaux, antiacides et adsorbants

+ SELS DE FER PAR VOIE INJECTABLE

	Lipothymie, voire choc attribué à la libération rapide du fer de sa forme complexe et à la saturation de la sidérophiline.	**Association DECONSEILLEE**

+ ACIDE ACETOHYDROXAMIQUE

	Diminution de l'absorption digestive de ces deux médicaments par chélation du fer.	**A prendre en compte**

+ BICTÉGRAVIR

	Diminution de près des deux tiers de l'absorption du bictégravir en cas d'ingestion simultanée ou à jeun.	**Précaution d'emploi** Prendre le bictégravir au moins 2 heures avant les sels de fer, ou en même temps qu'un repas.

+ BISPHOSPHONATES

	Pour les sels de fer administrés par voie orale : diminution de l'absorption digestive des bisphosphonates.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de fer à distance des bisphosphonates (de 30 minutes au minimum à plus de 2 heures, si possible, selon le bisphosphonate).

+ CALCIUM

	Avec les sels de fer par voie orale : diminution de l'absorption digestive des sels de fer.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de fer à distance des repas et en l'absence de calcium.

+ CYCLINES

	Diminution de l'absorption digestive des cyclines et du fer	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de fer à distance des cyclines (plus de 2 heures, si possible).

+ ENTACAPONE

	Diminution de l'absorption digestive de l'entacapone et du fer par chélation de celui-ci par l'entacapone.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de fer à distance de l'entacapone (plus de 2 heures si possible).

+ FLUOROQUINOLONES

	Diminution de l'absorption digestive des fluoroquinolones.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de fer à distance des fluoroquinolones (plus de 2 heures, si possible).

+ HORMONES THYROÏDIENNES

	Diminution de l'absorption digestive des hormones thyroïdiennes.	**Précaution d'emploi** Prendre les hormones thyroïdiennes à distance du fer (plus de 2 heures, si possible).

+ INHIBITEURS D'INTÉGRASE

	Diminution de l'absorption digestive des inhibiteurs d'intégrase.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de fer à distance de l'antirétroviral (plus de 2 heures, si possible).

+ *LEVODOPA*

	Diminution de l'absorption digestive de la lévodopa.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de fer à distance de la lévodopa (plus de 2 heures si possible).

+ *METHYLDOPA*

	Diminution de l'absorption digestive de la méthyldopa (formation de complexes).	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de fer à distance de la méthyldopa (plus de deux heures, si possible).

+ *PENICILLAMINE*

	Diminution de l'absorption digestive de la pénicillamine.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de fer à distance de la pénicillamine (plus de 2 heures, si possible).

+ *ROXADUSTAT*

	La prise de cation divalent peut diminuer l'absorption intestinale et, potentiellement, l'efficacité du roxadustat pris simultanément.	**Précaution d'emploi** Prendre le roxadustat à distance des sels de fer (plus de 1 heure, si possible).

+ *STRONTIUM*

	Diminution de l'absorption digestive du strontium.	**Précaution d'emploi** Prendre le strontium à distance des sels de fer (plus de deux heures, si possible).

+ *TRIENTINE*

	Diminution des concentrations de fer sérique.	**Précaution d'emploi** Prendre la trientine à distance des sels de fer.

+ *ZINC*

	Diminution de l'absorption digestive du zinc par le fer.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de fer à distance du zinc (plus de 2 heures si possible).

FEXOFENADINE

Voir aussi : substances à absorption réduite par les topiques gastro-intestinaux, antiacides et adsorbants

+ *MILLEPERTUIS*

	Diminution des concentrations plasmatiques de la féxofénadine par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**

FIBRATES

(bezafibrate, ciprofibrate, fenofibrate, gemfibrozil)

+ *FIBRATES (AUTRES)*

	Risque majoré d'effets indésirables à type de rhabdomyolyse et d'antagonisme pharmacodynamique entre les deux molécules.	**CONTRE-INDICATION**

+ *ANTIVITAMINES K*

	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par le fibrate et 8 jours après son arrêt.

+ *COLCHICINE*

	Risque de majoration des effets indésirables musculaires de ces substances, et notamment de rhabdomyolyse.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique, particulièrement au début de l'association.

+ *INHIBITEURS DE L'HMG-COA RÉDUCTASE (STATINES)*

	Risque d'addition d'effets indésirables (dose-dépendants) à type de rhabdomyolyse. En outre, avec le gemfibrozil, diminution du métabolisme de la simvastatine et de la rosuvastatine, ce qui majore le risque musculaire, ainsi que la néphrotoxicité de la rosuvastatine.	**CI - ASDEC** L'association d'un fibrate et d'une statine est au minmum déconseillée. Avec la simvastatine, ne pas dépasser 10 mg (cette restriction de doses ne concerne pas le fénofibrate). La contre-indication s'applique : - entre le gemfibrozil et la simvastatine - pour des doses de rosuvastatine de 40 mg

+ *VALGANCICLOVIR*

	Risque de majoration de la toxicité hématologique.	**A prendre en compte**

+ *ZIDOVUDINE*

	Augmentation de la toxicité hématologique (addition d'effets de toxicité médullaire).	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'hémogramme.

FLUDARABINE

Voir aussi : cytotoxiques

+ *PENTOSTATINE*

	Majoration du risque de toxicité pulmonaire pouvant être fatale.	**Association DECONSEILLEE**

FLUOROQUINOLONES

(ciprofloxacine, délafloxacine, enoxacine, levofloxacine, lomefloxacine, moxifloxacine, norfloxacine, ofloxacine, pefloxacine)

+ *ANTIVITAMINES K*

	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par la fluoroquinolone et après son arrêt.

+ *FER*

	Diminution de l'absorption digestive des fluoroquinolones.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de fer à distance des fluoroquinolones (plus de 2 heures, si possible).

+ *GLUCOCORTICOÏDES (SAUF HYDROCORTISONE)*

	Possible majoration du risque de tendinopathie, voire de rupture tendineuse (exceptionnelle), particulièrement chez les patients recevant une corticothérapie prolongée.	**A prendre en compte**

+ *MYCOPHENOLATE MOFETIL*

	Diminution des concentrations de l'acide mycophénolique d'environ un tiers, avec risque potentiel de baisse d'efficacité.	**A prendre en compte**

+ *STRONTIUM*

	Diminution de l'absorption digestive du strontium.	**Précaution d'emploi** Prendre le strontium à distance des fluoroquinolones (plus de deux heures, si possible).

+ *SUCRALFATE*

	Diminution de l'absorption digestive des fluoroquinolones.	**Précaution d'emploi** Prendre le sucralfate à distance des fluoroquinolones (plus de 2 heures, si possible).

+ *ZINC*

	Diminution de l'absorption digestive des fluoroquinolones.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de zinc à distance des fluoroquinolones (plus de 2 heures, si possible).

FLUOROURACILE (ET, PAR EXTRAPOLATION, AUTRES FLUOROPYRIMIDINES)

(capecitabine, fluorouracile, giméracil, otéracil, tegafur)

+ *ACIDE FOLINIQUE*

	Potentialisation des effets, à la fois cytostatiques et indésirables, du fluoro-uracile.	**A prendre en compte**

+ *ANTIVITAMINES K*

	Augmentation importante de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Association DECONSEILLEE** Si elle ne peut être évitée, contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par le cytotoxique et 8 jours après son arrêt.

+ *INTERFERON ALFA*

	Augmentation de la toxicité gastro-intestinale du fluorouracile.	**A prendre en compte**

HÉPARINES (DOSES PRÉVENTIVES)

(dalteparine sodique, danaparoide sodique, enoxaparine, fondaparinux, heparine calcique, heparine sodique, nadroparine calcique, reviparine, tinzaparine)

+ ACIDE ACETYLSALICYLIQUE		
	L'utilisation conjointe de médicaments agissant à divers niveaux de l'hémostase majore le risque de saignement. Ainsi, chez le sujet de moins de 65 ans, l'association de l'héparine à doses préventives, ou de substances apparentées, à l'acide acétylsalicylique, quelle que soit la dose, doit être prise en compte en maintenant une surveillance clinique et éventuellement biologique.	**A prendre en compte**
+ ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS		
	Augmentation du risque hémorragique.	**A prendre en compte**

HORMONES THYROÏDIENNES

(levothyroxine, liothyronine sodique, thyroxines, tiratricol)

+ ANTISÉCRÉTOIRES INHIBITEURS DE LA POMPE À PROTONS		
	Diminution probable de l'absorption des hormones thyroïdiennes, par augmentation du pH intra-gastrique par l'antisécrétoire.	**Précaution d'emploi** Contrôle clinique et biologique régulier, avec augmentation éventuelle de la posologie des hormones thyroïdiennes.
+ CALCIUM		
	Diminution de l'absorption digestive des hormones thyroïdiennes.	**Précaution d'emploi** Prendre les sels de calcium à distance des hormones thyroïdiennes (plus de 2 heures, si possible).
+ CHLOROQUINE		
	Risque d'hypothyroïdie clinique chez les patients substitués par hormones thyroïdiennes.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique. Adaptation, si besoin, de la posologie des hormones thyroïdiennes pendant le traitement par chloroquine et après son arrêt.
+ EFAVIRENZ		
	Risque d'hypothyroïdie clinique chez les patients hypothyroïdiens, par augmentation du métabolisme de la T3 et de la T4.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique. Adaptation, si besoin, de la posologie des hormones thyroïdiennes pendant le traitement par l'inducteur et après son arrêt.
+ ESTROGÈNES NON CONTRACEPTIFS		
	Risque d'hypothyroïdie clinique en cas d'estrogénothérapie substitutive.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique ; adaptation éventuelle des doses de l'hormone thyroïdienne chez les femmes ménopausées prenant des estrogènes.
+ FER		
	Diminution de l'absorption digestive des hormones thyroïdiennes.	**Précaution d'emploi** Prendre les hormones thyroïdiennes à distance du fer (plus de 2 heures, si possible).
+ INDUCTEURS ENZYMATIQUES PUISSANTS		
	Risque d'hypothyroïdie clinique chez les patients hypothyroïdiens, par augmentation du métabolisme de la T3 et de la T4.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique. Adaptation, si besoin, de la posologie des hormones thyroïdiennes pendant le traitement par l'inducteur et après son arrêt.
+ INHIBITEURS DE PROTÉASES BOOSTÉS PAR RITONAVIR		
	Risque de baisse de l'efficacité des hormones thyroïdiennes par augmentation de leur métabolisme hépatique par le ritonavir.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique et adaptation éventuelle de la posologie des hormones thyroïdiennes.
+ MILLEPERTUIS		
	Risque de baisse de l'efficacité des hormones thyroïdiennes.	**Association DECONSEILLEE**
+ ORLISTAT		
	Risque de déséquilibre du traitement thyroïdien substitutif en cas de traitement par orlistat.	**A prendre en compte**
+ PROGUANIL		
	Risque d'hypothyroïdie clinique chez les patients substitués par hormones thyroïdiennes.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique. Adaptation, si besoin, de la posologie des hormones thyroïdiennes pendant le traitement par l'antipaludique et après son arrêt.

+ *RÉSINES CHÉLATRICES*

	Diminution de l'absorption digestive des hormones thyroïdiennes.	**Précaution d'emploi** Prendre les hormones thyroïdiennes à distance de la résine (plus de 2 heures, si possible).

+ *RIFABUTINE*

	Décrit pour la phénytoïne, la rifampicine, la carbamazépine. Risque d'hypothyroïdie clinique chez les patients hypothyroïdiens, par augmentation du métabolisme de la T3 et de la T4.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique. Adaptation, si besoin, de la posologie des hormones thyroïdiennes pendant le traitement par la rifabutine et après son arrêt.

+ *RIFAMPICINE*

	Risque d'hypothyroïdie clinique chez les patients hypothyroïdiens, par augmentation du métabolisme de la T3 et de la T4.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique. Adaptation, si besoin, de la posologie des hormones thyroïdiennes pendant le traitement par la rifampicine et après son arrêt.

+ *SELPERCATINIB*

	Risque de moindre efficacité de la supplémentation en lévothyroxine par baisse de la conversion de T4 en T3 en cas de traitement par selpercatinib.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique, et adjonction éventuelle de liothyronine au traitement par la lévothyroxine.

+ *SUCRALFATE*

	Diminution de l'absorption digestive des hormones thyroïdiennes.	**Précaution d'emploi** Prendre les hormones thyroïdiennes à distance du sucralfate (plus de 2 heures, si possible).

HUILES MINÉRALES

(paraffine, silicone)

+ *PRÉSERVATIFS EN LATEX*

	Risque de rupture du préservatif lors de l'utilisation avec des corps gras ou des lubrifiants contenant des huiles minérales (huile de paraffine, huile de silicone, etc...).	**CONTRE-INDICATION** Utiliser un lubrifiant hydrosoluble (glycérine, polyacrylamide...).

HYDROCORTISONE

Voir aussi : corticoïdes - hypokaliémiants

+ *INDUCTEURS ENZYMATIQUES*

	Risque de diminution de l'efficacité de l'hydrocortisone (augmentation de son métabolisme) ; les conséquences sont graves lorsque l'hydrocortisone est administrée en traitement substitutif ou en cas de transplantation.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique ; adaptation de la posologie de l'hydrocortisone pendant l'association et après l'arrêt de l'inducteur enzymatique.

HYDROQUINIDINE

Voir aussi : antiarythmiques - antiarythmiques classe Ia - bradycardisants - substances susceptibles de donner des torsades de pointes - torsadogènes (sauf arsénieux, antiparasitaires, neuroleptiques, méthadone...)

+ *ALCALINISANTS URINAIRES*

	Augmentation des concentrations plasmatiques de l'hydroquinidine et risque de surdosage (diminution de l'excrétion rénale de l'hydroquinidine par alcalinisation des urines).	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique, ECG et éventuellement contrôle des concentrations de l'hydroquinidine ; si besoin, adaptation de la posologie pendant le traitement alcalinisant et après son arrêt.

+ *DIGOXINE*

	Augmentation de la digoxinémie par diminution de la clairance rénale de la digoxine. De plus, troubles de l'automatisme (bradycardie excessive et troubles de la conduction auriculo-ventriculaire).	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et ECG. En cas de réponse inattendue, contrôler la digoxinémie et adapter la posologie.

+ *ITRACONAZOLE*

	Risque d'acouphènes et/ou de diminution de l'acuité auditive : cinchonisme lié à une diminution du métabolisme hépatique de l'antiarythmique par l'itraconazole.	**Précaution d'emploi** Surveillance des concentrations plasmatiques de l'antiarythmique et diminution éventuelle de sa posologie si nécessaire.

HYDROXYCARBAMIDE

Voir aussi : cytotoxiques

+ *VACCINS VIVANTS ATTÉNUÉS*

	Dans son indication chez le patient drépanocytaire, risque théorique de maladie vaccinale généralisée.	**Association DECONSEILLEE** L'association ne devra être envisagée que si les bénéfices sont estimés comme étant supérieurs à ce risque. S'il est décidé d'interrompre le traitement par hydroxycarbamide pour effectuer la vaccination, un délai de 3 mois après l'arrêt est recommandé.

+ *PETHIDINE*

	Manifestations d'excitation centrale évoquant un syndrome sérotoninergique : diarrhée, tachycardie, sueurs, tremblements, confusion voire coma.	**CONTRE-INDICATION**

+ *TRAMADOL*

	Risque d'apparition d'un syndrome sérotoninergique.	**A prendre en compte**

+ *TRIPTANS MÉTABOLISÉS PAR LA MAO*

	Risque d'hypertension artérielle, de vasoconstriction artérielle coronaire.	**CONTRE-INDICATION**

+ *TRIPTANS NON MÉTABOLISÉS PAR LA MAO*

	Risque d'hypertension artérielle, de vasoconstriction artérielle coronaire.	**Association DECONSEILLEE**

IMATINIB

Voir aussi : inhibiteurs de tyrosine kinases métabolisés - médicaments à l'origine d'atteintes musculaires - substrats à risque du CYP3A4

+ *ANTICOAGULANTS ORAUX*

	Augmentation du risque hémorragique. Pour l'apixaban et le rivaroxaban, risque de diminution de leur métabolisme par l'imatinib, se surajoutant au risque pharmacodynamique.	**Association DECONSEILLEE** Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique et biologique étroite (pour les antivitamines K, contrôle plus fréquent de l'INR).

+ *IBRUTINIB*

	Risque d'augmentation des concentrations plasmatiques d'ibrutinib par diminution de son métabolisme hépatique par l'imatinib.	**Association DECONSEILLEE** Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique étroite et réduction de la dose d'ibrutinib à 280 mg par jour pendant la durée de l'association.

+ *TÉDIZOLIDE*

	Risque d'augmentation des concentrations plasmatiques de l'imatinib, par augmentation de son absorption avec le tédizolide administré par voie orale.	**Association DECONSEILLEE**

IMMUNOSUPPRESSEURS

(ciclosporine, everolimus, sirolimus, tacrolimus, temsirolimus)

+ *APALUTAMIDE*

	Risque de diminution très importante des concentrations des immunosuppresseurs, et perte d'efficacité, par augmentation de leur métabolisme hépatique par l'apalutamide.	**Association DECONSEILLEE**

+ *CLARITHROMYCINE*

	Augmentation très importante des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur par inhibition de son métabolisme hépatique.	**Association DECONSEILLEE** En cas d'association, contrôle strict de la fonction rénale, dosage des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur et adaptation éventuelle de la posologie.

+ *CYTOTOXIQUES*

	Immunodépression excessive avec risque de syndrome lympho-prolifératif.	**A prendre en compte**

+ *DALFOPRISTINE*

	Augmentation des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur par inhibition de son métabolisme hépatique.	**Précaution d'emploi** Dosage des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur, contrôle de la fonction rénale et adaptation de la posologie pendant l'association et après son arrêt.

+ *DILTIAZEM*

	Augmentation des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur par diminution de son métabolisme.	**Précaution d'emploi** Dosage des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur, contrôle de la fonction rénale et adaptation de la posologie pendant l'association et après son arrêt.

+ *DRONEDARONE*

	Augmentation importante des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur par diminution de son métabolisme.	**Association DECONSEILLEE**

+ *ERYTHROMYCINE*		
	Augmentation très importante des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur par inhibition de son métabolisme hépatique.	**Association DECONSEILLEE** En cas d'association, contrôle strict de la fonction rénale, dosage des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur et adaptation éventuelle de la posologie.
+ *FLUCONAZOLE*		
	Risque d'augmentation des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur par inhibition de son métabolisme et de la créatininémie.	**Précaution d'emploi** Dosage des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur, contrôle de la fonction rénale et adaptation de sa posologie pendant l'association et après son arrêt.
+ *FLUCYTOSINE*		
	Risque de majoration de la toxicité hématologique.	**A prendre en compte**
+ *GLOBULINES ANTILYMPHOCYTAIRES*		
	Immunodépression excessive avec risque de lymphoprolifération.	**A prendre en compte**
+ *INDUCTEURS ENZYMATIQUES*		
	Diminution des concentrations sanguines et de l'efficacité de l'immunosuppresseur, par augmentation de son métabolisme hépatique par l'inducteur.	**Précaution d'emploi** Augmentation de la posologie de l'immunosuppresseur sous contrôle des concentrations sanguines. Réduction de la posologie après l'arrêt de l'inducteur.
+ *INHIBITEURS DE PROTÉASES BOOSTÉS PAR RITONAVIR*		
	Augmentation très importante des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur par inhibition de son métabolisme hépatique.	**Association DECONSEILLEE** En cas d'association, contrôle strict de la fonction rénale, dosage des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur et adaptation de sa posologie.
+ *ITRACONAZOLE*		
	Augmentation très importante des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur par inhibition de son métabolisme hépatique.	**Association DECONSEILLEE** En cas d'association, contrôle strict de la fonction rénale, dosage des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur et adaptation éventuelle de la posologie.
+ *KETOCONAZOLE*		
	Augmentation très importante des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur par inhibition de son métabolisme hépatique.	**Association DECONSEILLEE** En cas d'association, contrôle strict de la fonction rénale, dosage des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur et adaptation éventuelle de la posologie.
+ *LÉTERMOVIR*		
	Augmentation, éventuellement très importante, des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur par inhibition de son métabolisme et de la créatininémie.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique renforcée.
+ *MARIBAVIR*		
	Possible augmentation des concentrations de l'immunosuppresseur.	**Précaution d'emploi** Dosage des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur, contrôle de la fonction rénale et adaptation éventuelle de la posologie pendant l'association et après son arrêt.
+ *MILLEPERTUIS*		
	Diminution des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur, en raison de l'effet inducteur enzymatique du millepertuis, avec risque de baisse d'efficacité voire d'annulation de l'effet dont les conséquences peuvent être éventuellement graves (rejet de greffe).	**CONTRE-INDICATION**
+ *NICARDIPINE*		
	Augmentation des concentrations sanguines de l'immunodépresseur, par inhibition de son métabolisme.	**Précaution d'emploi** Dosage des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur, contrôle de la fonction rénale et adaptation de sa posologie pendant le traitement et après l'arrêt.
+ *PAMPLEMOUSSE (JUS ET FRUIT)*		
	Augmentation de la biodisponibilité de l'immunosuppresseur et par conséquent de ses effets indésirables.	**Association DECONSEILLEE**
+ *POSACONAZOLE*		
	Augmentation très importante des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur par inhibition de son métabolisme hépatique.	**Association DECONSEILLEE** En cas d'association, contrôle strict de la fonction rénale, dosage des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur et adaptation éventuelle de la posologie.

+ *PRISTINAMYCINE*

	Augmentation des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur par inhibition de son métabolisme hépatique.	**Précaution d'emploi** Dosage des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur, contrôle de la fonction rénale et adaptation de sa posologie pendant l'association et après son arrêt.

+ *QUINUPRISTINE*

	Augmentation des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur par inhibition de son métabolisme hépatique.	**Précaution d'emploi** Dosage des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur, contrôle de la fonction rénale et adaptation de la posologie pendant l'association et après son arrêt.

+ *RANOLAZINE*

	Augmentation des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur par inhibition de son métabolisme par la ranolazine.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique, et adaptation éventuelle de la posologie de l'immunosuppresseur.

+ *STIRIPENTOL*

	Augmentation des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur (diminution de son métabolisme hépatique).	**CONTRE-INDICATION**

+ *TELITHROMYCINE*

	Augmentation très importante des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur par inhibition de son métabolisme hépatique.	**Association DECONSEILLEE** En cas d'association, contrôle strict de la fonction rénale, dosage des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur et adaptation éventuelle de la posologie.

+ *VACCINS VIVANTS ATTÉNUÉS*

	Risque de maladie vaccinale généralisée éventuellement mortelle.	**CONTRE-INDICATION** Et pendant les 3 mois suivant l'arrêt du traitement.

+ *VÉMURAFÉNIB*

	Risque de diminution des concentrations des immunosuppresseurs, avec pour conséquence un risque d'inefficacité.	**Association DECONSEILLEE**

+ *VORICONAZOLE*

	Augmentation des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur par inhibition de son métabolisme hépatique par le voriconazole.	**ASDEC - PE** Association déconseillée - avec l'évérolimus, le sirolimus, et le temsirolimus. Précaution d'emploi - avec la ciclosporine et le tacrolimus : dosage des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur, contrôle de la fonction rénale et adaptation de la posologie pendant l'association et après son arrêt.

INDUCTEURS ENZYMATIQUES

Certains médicaments ont la propriété d'activer considérablement certaines voies métaboliques hépatiques par induction enzymatique. Associés à des médicaments fortement métabolisés au niveau du foie, ils sont, de ce fait, en mesure d'en modifier les concentrations plasmatiques. Il peut s'ensuivre, dans la majorité des cas, une moindre activité des médicaments associés à l'inducteur, voire la formation de métabolites toxiques.
Les inducteurs enzymatiques à l'origine d'interactions cliniquement pertinentes sont notamment représentés par certains antiépileptiques, certains antituberculeux et antirétroviraux et le millepertuis (pour ce dernier, se reporter aux interactions qui lui sont propres).
Les médicaments dont l'efficacité peut être altérée sont nombreux : immunosuppresseurs, estroprogestatifs et progestatifs, inhibiteurs de protéase, anticoagulants oraux, glucocorticoïdes, hormones thyroïdiennes, antagonistes du calcium, isoniazide, théophylline, etc…

(apalutamide, carbamazepine, cénobamate, dabrafénib, efavirenz, enzalutamide, eslicarbazépine, fosphenytoine, létermovir, lorlatinib, lumacaftor, nevirapine, oxcarbazepine, phenobarbital, phenytoine, pitolisant, primidone, rifabutine, rifampicine, sotorasib)

+ *ANDROGÈNES*

	Risque de diminution des concentrations plasmatiques de l'androgène et par conséquent de son efficacité, par augmentation de son métabolisme hépatique par l'inducteur.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique pendant l'association et 1 à 2 semaines après l'arrêt de l'inducteur.

+ *APRÉMILAST*

	Diminution des concentrations plasmatiques d'aprémilast par augmentatiion de son métabolisme par l'inducteur.	**Association DECONSEILLEE**

+ *ARIPIPRAZOLE*

	Diminution des concentrations plasmatiques de l'aripiprazole.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et adaptation éventuelle de la posologie de l'aripiprazole pendant l'association et 1 à 2 semaines après l'arrêt de l'inducteur.

+ *GLIPTINES*		
	Risque de majoration de la survenue d'un angio-œdème d'origine bradykinique pouvant être fatal.	**A prendre en compte**
+ *INSULINE*		
	L'utilisation des IEC peut entraîner une majoration de l'effet hypoglycémiant chez le diabétique traité par insuline. La survenue de malaises hypoglycémiques semble exceptionnelle (amélioration de la tolérance au glucose qui aurait pour conséquence une réduction des besoins en insuline).	**Précaution d'emploi** Renforcer l'autosurveillance glycémique.
+ *LITHIUM*		
	Augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques (diminution de l'excrétion rénale du lithium).	**Association DECONSEILLEE** Si l'usage d'un IEC est indispensable, surveillance stricte de la lithémie et adaptation de la posologie du lithium.
+ *OR*		
	Avec les sels d'or administrés par voie IV : risque de réaction «nitritoïde» à l'introduction de l'IEC (nausées, vomissements, effets vasomoteurs à type de flush, hypotension, éventuellement collapsus).	**A prendre en compte**
+ *POTASSIUM*		
	Pour une quantité de potassium > à 1 mmol/prise, hyperkaliémie potentiellement létale, notamment chez l'insuffisant rénale (addition des effets hyperkaliémiants).	**Association DECONSEILLEE** Sauf s'il existe une hypokaliémie.
+ *SACUBITRIL*		
	Augmentation du risque d'angioedème.	**CONTRE-INDICATION**
+ *SIROLIMUS*		
	Majoration du risque d'angio-oedème.	**A prendre en compte**
+ *SPIRONOLACTONE*		
	Avec la spironolactone à la posologie de 12,5 à 50 mg par jour, et avec des doses faibles d'IEC. Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque de classe III ou IV (NYHA) avec fraction d'éjection <35 % et préalablement traitée par l'association inhibiteur de conversion + diurétique de l'anse : risque d'hyperkaliémie, potentiellement létale, en cas de non-respect des conditions de prescription de cette association.	**Précaution d'emploi** Vérifier au préalable l'absence d'hyperkaliémie et d'insuffisance rénale. Surveillance biologique étroite de la kaliémie et de la créatininémie (1 fois par semaine pendant le premier mois, puis une fois par mois ensuite).
+ *SULFAMIDES HYPOGLYCÉMIANTS*		
	L'utilisation des IEC peut entraîner une majoration de l'effet hypoglycémiant chez le diabétique traité par sulfamides hypoglycémiants. La survenue de malaises hypoglycémiques semble exceptionnelle (amélioration de la tolérance au glucose qui aurait pour conséquence une réduction des besoins en sulfamides hypoglycémiants).	**Précaution d'emploi** Renforcer l'autosurveillance glycémique.
+ *TEMSIROLIMUS*		
	Majoration du risque d'angio-oedème.	**A prendre en compte**

INHIBITEURS DE L'HMG-COA RÉDUCTASE (STATINES)

(atorvastatine, fluvastatine, pitavastatine, pravastatine, rosuvastatine, simvastatine)

+ *ACIDE FUSIDIQUE*		
	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse.	**CONTRE-INDICATION** Arrêter le traitement par l'inhibiteur de l'HMG Co-A réductase avant d'initier un traitement par acide fusidique ou utiliser un autre antibiotique.
+ *ANTIVITAMINES K*		
	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K.
+ *COBIMÉTINIB*		
	Risque majoré de rhabdomyolyse.	**A prendre en compte**

+ *COLCHICINE*		
	Risque de majoration des effets indésirables musculaires de ces substances, et notamment de rhabdomyolyse.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique, notamment au début de l'association.
+ *DAPTOMYCINE*		
	Risque d'addition des effets indésirables (dose-dépendant) à type de rhabdomyolyse.	**Association DECONSEILLEE** Si l'association ne peut être évitée, renforcer la surveillance biologique (dosage des CPK plus d'une fois par semaine) et surveillance clinique étroite.
+ *ELTROMBOPAG*		
	Risque de majoration de la toxicité des statines, par inhibition de leur recapture hépatique.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et adaptation éventuelle de la posologie de la statine.
+ *FIBRATES*		
	Risque d'addition d'effets indésirables (dose-dépendants) à type de rhabdomyolyse. En outre, avec le gemfibrozil, diminution du métabolisme de la simvastatine et de la rosuvastatine, ce qui majore le risque musculaire, ainsi que la néphrotoxicité de la rosuvastatine.	**CI - ASDEC** L'association d'un fibrate et d'une statine est au minmum déconseillée. Avec la simvastatine, ne pas dépasser 10 mg (cette restriction de doses ne concerne pas le fénofibrate). La contre-indication s'applique : - entre le gemfibrozil et la simvastatine - pour des doses de rosuvastatine de 40 mg
+ *GLIPTINES*		
	Possibilité de survenue d'effets indésirables musculaires à l'introduction d'une gliptine, malgré le traitement antérieur par statine bien toléré.	**Précaution d'emploi** Le contrôle régulier de la fonction rénale et le strict respect des doses sont impératifs.
+ *GRAZOPREVIR + ELBASVIR*		
	Augmentation des concentrations plasmatiques de l'hypochlestérolémiant par augmentation de son absorption intestinale.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique pendant l'association. La dose de statine ne doit pas dépasser 20 mg par jour (10 mg avec la rosuvastatine).
+ *LÉDIPASVIR*		
	Risque d'augmentation des concentrations plasmatiques de la statine et de ses effets indésirables à type de rhabdomyolyse.	**CI - PE** Contre-indication : - avec la rosuvastatine. Précaution d'emploi : - avec les autres inhibiteurs de l'HMG Co-A réductase. Surveillance clinique et biologique. Adaptation éventuelle de la posologie de la statine.
+ *LENALIDOMIDE*		
	Risque majoré de survenue de rhabdomyolyses.	**Précaution d'emploi** Renforcer le contrôle clinique et biologique, notamment durant les premières semaines de traitement.
+ *LÉTERMOVIR*		
	Risque d'augmentation des concentrations plasmatiques de la statine et de ses effets indésirables à type de rhabdomyolyse.	**ASDEC - PE** Association déconseillée: - avec simvastatine, pitavastatine, rosuvastatine Précaution d'emploi (en cas d'utilisation du létermovir seul): - ne pas dépasser 20 mg/ jour d'atorvastatine - adaptation éventuelle de la posologie de fluvastatine et de pravastatine,
+ *ROXADUSTAT*		
	Augmentation d'un facteur 2 à 3 de l'exposition de la statine, par diminution de son métabolisme par le roxadustat.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et adaptation de la posologie de la statine pendant le traitement par roxadustat.

INHIBITEURS DE PROTÉASES BOOSTÉS PAR RITONAVIR

Le ritonavir est désormais utilisé à la dose de 100 mg 2 fois par jour en association à un autre inhibiteur de protéase, dans le but d'augmenter de façon très significative la biodisponibilité de l'inhibiteur de protéase associé (ou boosté), ce qui permet d'augmenter ainsi l'efficacité du traitement antirétroviral. Eu égard à ce schéma thérapeutique, chaque inhibiteur de protéase acquiert de la sorte les propriétés d'inhibition puissante du CYP3A4 que possède le ritonavir, et ce, même lorsque celui-ci est donné à doses 6 fois moindres que lors des premières années de son utilisation. En pratique, ceci revient donc à considérer tous les inhibiteurs de protéase comme des inhibiteurs enzymatiques de puissance comparable. Par conséquent, les interactions communes à cette classe découlent, pour la plupart, de cette propriété.

(atazanavir, darunavir, fosamprenavir, lopinavir, nirmatrelvir, ritonavir, saquinavir, tipranavir)

+ AFATINIB		
	Augmentation des concentrations plasmatiques d'afatinib par augmentation de son absorption par l'inhibiteur de protéases.	**Précaution d'emploi** Il est recommandé d'administrer l'inhibiteur de protéases le plus à distance possible de l'afatinib, en respectant de préférence un intervalle de 6 heures ou de 12 heures par rapport à la prise d'afatinib.
+ ALBENDAZOLE		
	Diminution importante des concentrations plasmatiques de l'albendazole et de son métabolite actif par le ritonavir, avec risque de baisse de son efficacité.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique de la réponse thérapeutique et adaptation éventuelle de la posologie de l'albendazole pendant le traitement avec l'inducteur enzymatique et après son arrêt.
+ ANTIVITAMINES K		
	Variation de l'effet de l'antivitamine K, le plus souvent dans le sens d'une diminution.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant la durée du traitement.
+ ATORVASTATINE		
	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse (diminution du métabolisme hépatique de l'atorvastatine).	**Association DECONSEILLEE** Utiliser des doses plus faibles d'atorvastatine. Si l'objectif thérapeutique n'est pas atteint, utiliser une autre statine non concernée par ce type d'interaction.
+ ATOVAQUONE		
	Diminution, éventuellement très importante, des concentrations plasmatiques de l'atovaquone par augmentation de son métabolisme.	**Association DECONSEILLEE**
+ BUPRENORPHINE		
	Risque de majoration ou de diminution des effets de la buprénorphine, à la fois par inhibition et accélération de son métabolisme par l'inhibiteur de protéases.	**A prendre en compte**
+ CLARITHROMYCINE		
	Augmentation des concentrations de la clarithromycine et de son métabolite actif par diminution de son métabolisme hépatique par l'inhibiteur de protéases.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique régulière, notamment en début d'association.
+ CYPROTERONE		
	Risque de diminution de l'efficacité de la cyprotérone.	**ASDEC - PE** Association déconseillée - dans son utilisation comme contraceptif hormonal: utiliser de préférence une autre méthode de contraception en particulier de type mécanique, pendant la durée de l'association et un cycle suivant. Précaution d'emploi - dans ses indications comme anti-androgène: surveillance clinique et adaptation éventuelle de la posologie de la cyprotérone pendant l'association et après son arrêt.
+ DIGOXINE		
	Augmentation de la digoxinémie, plus marquée pour la voie intraveineuse, par augmentation de l'absorption de la digoxine ou diminution de sa clairance rénale.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et, s'il y a lieu, de l'ECG et de la digoxinémie, avec adaptation éventuelle de la posologie de digoxine.
+ ESTROPROGESTATIFS CONTRACEPTIFS		
	Risque de diminution de l'efficacité contraceptive par diminution des concentrations en contraceptif hormonal, dûe à l'augmentation de son métabolisme hépatique par le ritonavir.	**Association DECONSEILLEE** Utiliser une méthode additionnelle de type mécanique (préservatif) pendant la durée de l'association, et un cycle suivant l'arrêt du ritonavir.
+ HORMONES THYROÏDIENNES		
	Risque de baisse de l'efficacité des hormones thyroïdiennes par augmentation de leur métabolisme hépatique par le ritonavir.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique et adaptation éventuelle de la posologie des hormones thyroïdiennes.
+ IMMUNOSUPPRESSEURS		
	Augmentation très importante des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur par inhibition de son métabolisme hépatique.	**Association DECONSEILLEE** En cas d'association, contrôle strict de la fonction rénale, dosage des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur et adaptation de sa posologie.

+ FLUOXETINE		
	Risque de majoration des effets indésirables de la méquitazine, par inhibition de son métabolisme par l'inhibiteur enzymatique.	**Association DECONSEILLEE**
+ PAROXETINE		
	Risque de majoration des effets indésirables de la méquitazine, par inhibition de son métabolisme par l'inhibiteur enzymatique.	**Association DECONSEILLEE**
+ TERBINAFINE		
	Risque de majoration des effets indésirables de la méquitazine, par inhibition de son métabolisme par l'inhibiteur enzymatique.	**Association DECONSEILLEE**

METFORMINE

+ ALCOOL (BOISSON OU EXCIPIENT)		
	Risque majoré d'acidose lactique lors d'intoxication alcoolique aiguë, particulièrement en cas de jeûne ou dénutrition, ou bien d'insuffisance hépatocellulaire.	**Association DECONSEILLEE** Eviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.
+ DIURÉTIQUES DE L'ANSE		
	Acidose lactique due à la metformine, déclenchée par une éventuelle insuffisance rénale fonctionnelle, liée aux diurétiques de l'anse.	**Précaution d'emploi** Ne pas utiliser la metformine lorsque la créatininémie dépasse 15 mg/l (135 µmol/l) chez l'homme, et 12 mg/l (110 µmol/l) chez la femme.
+ DOLUTÉGRAVIR		
	Augmentation moyenne de moins de deux fois des concentrations plasmatiques de metformine.	**Précaution d'emploi** Chez le patient avec une insuffisance rénale modérée, surveillance clinique et éventuelle réduction supplémentaire de la posologie de metformine.
+ PRODUITS DE CONTRASTE IODÉS		
	Risque important d'acidose lactique par hémoconcentration de la metformine, dans le cas d'un arrêt cardio-respiratoire induit par l'examen radiologique, avec insuffisance rénale aiguë.	**CONTRE-INDICATION** Le traitement par la metformine doit être suspendu au moment de l'examen radiologique pour n'être repris que 2 jours après.
	Risque important d'acidose lactique par hémoconcentration de la metformine, dans le cas d'un arrêt cardio-respiratoire induit par l'examen radiologique, avec insuffisance rénale aiguë.	**CONTRE-INDICATION** Le traitement par la metformine doit être suspendu au moment de l'examen radiologique pour n'être repris que 2 jours après.
	Risque important d'acidose lactique par hémoconcentration de la metformine, dans le cas d'un arrêt cardio-respiratoire induit par l'examen radiologique, avec insuffisance rénale aiguë.	**CONTRE-INDICATION** Le traitement par la metformine doit être suspendu au moment de l'examen radiologique pour n'être repris que 2 jours après.

METHADONE

Voir aussi : morphiniques - morphiniques en traitement de substitution - médicaments sédatifs - médicaments à risque lors du sevrage tabagique - substances susceptibles de donner des torsades de pointes

+ ANTITUSSIFS MORPHINE-LIKE		
	Risque majoré de dépression respiratoire, pouvant être fatale en cas de surdosage.	**A prendre en compte**
+ ANTITUSSIFS MORPHINIQUES VRAIS		
	Risque majoré de dépression respiratoire, pouvant être fatale en cas de surdosage.	**A prendre en compte**
+ APALUTAMIDE		
	Risque de diminution très importante des concentrations de la méthadone, et perte d'efficacité, par augmentation de son métabolisme hépatique par l'apalutamide.	**Association DECONSEILLEE**
+ CIMETIDINE		
	Augmentation des concentrations plasmatiques de méthadone avec surdosage et risque majoré d'allongement de l'intervalle QT et de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointes.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et électrocardiographique renforcée ; si besoin, adaptation de la posologie de la méthadone pendant le traitement par la cimétidine et après son arrêt.
+ FLUVOXAMINE		
	Augmentation des concentrations plasmatiques de méthadone avec surdosage et risque majoré d'allongement de l'intervalle QT et de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointes.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et électrocardiographique renforcée ; si besoin, adaptation de la posologie de la méthadone pendant le traitement par la fluvoxamine et après son arrêt.

+ *CICLOSPORINE*		
	Risque d'atteinte des macrophages spléniques et des cellules phagocytaires mononuclées.	**CONTRE-INDICATION**
+ *CORTICOÏDES*		
	Risque de moindre efficacité du mifamurtide.	**Association DECONSEILLEE**
+ *TACROLIMUS*		
	Risque d'atteinte des macrophages spléniques et des cellules phagocytaires mononuclées.	**CONTRE-INDICATION**

MILLEPERTUIS

Voir aussi : médicaments à l'origine d'un syndrome sérotoninergique

+ *ANTICONVULSIVANTS MÉTABOLISÉS*		
	Risque de diminution des concentrations plasmatiques et de l'efficacité de l'anticonvulsivant.	**CONTRE-INDICATION**
+ *ANTISÉCRÉTOIRES INHIBITEURS DE LA POMPE À PROTONS*		
	Risque d'inefficacité du traitement antisécrétoire par augmentation de son métabolisme par le millepertuis.	**A prendre en compte**
+ *ANTIVITAMINES K*		
	Diminution des concentrations plasmatiques de l'antivitamine K, en raison de son effet inducteur enzymatique, avec risque de baisse d'efficacité voire d'annulation de l'effet dont les conséquences peuvent être éventuellement graves (évènement thrombotique).	**CONTRE-INDICATION** En cas d'association fortuite, ne pas interrompre brutalement la prise de millepertuis mais contrôler l'INR avant puis après l'arrêt du millepertuis.
+ *BÉDAQUILINE*		
	Risque de diminution des concentrations plasmatiques de bédaquiline par augmentation de son métabolisme par l'inducteur.	**Association DECONSEILLEE**
+ *BICTÉGRAVIR*		
	Diminution très importante des concentrations de bictégravir, avec risque de perte d'efficacité.	**CONTRE-INDICATION**
+ *BUSPIRONE*		
	Risque de diminution des concentrations plasmatiques de la buspirone par augmentation de son métabolisme par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**
+ *CANNABIDIOL*		
	Diminution des concentrations plasmatiques de cannabidiol avec risque de perte d'efficacité.	**CONTRE-INDICATION**
+ *CARBAMAZEPINE*		
	Risque de diminution des concentrations plasmatiques et de l'efficacité de la carbamazepine.	**Association DECONSEILLEE**
+ *CLOZAPINE*		
	Risque d'inefficacité du traitement antipsychotique (diminution des concentrations plasmatiques de clozapine par augmentation de son métabolisme hépatique).	**CONTRE-INDICATION**
+ *COBICISTAT*		
	Risque de diminution de l'efficacité du cobicistat par augmentation de son métabolisme par l'inducteur.	**CONTRE-INDICATION**
+ *CYCLOPHOSPHAMIDE*		
	Risque d'augmentation des concentrations plasmatiques du métabolite actif du cyclophosphamide par le millepertuis, et donc de sa toxicité.	**CONTRE-INDICATION**

+ *CYPROTERONE*		
	Risque de diminution de l'efficacité de la cyprotérone, par augmentation de son métabolisme hépatique par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**
+ *DASABUVIR*		
	Risque de diminution des concentrations plasmatiques du dasabuvir par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**
+ *DIGOXINE*		
	Diminution de la digoxinémie, en raison de l'effet inducteur du millepertuis, avec risque de baisse d'efficacité voire d'annulation de l'effet, dont les conséquences peuvent être éventuellement graves (décompensation d'une insuffisance cardiaque).	**CONTRE-INDICATION** En cas d'association fortuite, ne pas interrompre brutalement la prise de millepertuis mais contrôler les concentrations plasmatiques (ou l'efficacité) de la digoxine avant puis après l'arrêt du millepertuis.
+ *DOCETAXEL*		
	Risque de moindre efficacité du taxane par augmentation de son métabolisme par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**
+ *DOLUTÉGRAVIR*		
	Risque de diminution des concentrations plasmatiques de dolutégravir par augmentation de son métabolisme par le millepertuis.	**Association DECONSEILLEE**
+ *DRONEDARONE*		
	Diminution importante des concentrations de dronédarone par augmentation de son métabolisme, sans modification notable du métabolite actif.	**Association DECONSEILLEE**
+ *EFAVIRENZ*		
	Risque de diminution des concentrations d'éfavirenz, avec baisse d'efficacité.	**CONTRE-INDICATION**
+ *ESTROPROGESTATIFS CONTRACEPTIFS*		
	Diminution des concentrations plasmatiques du contraceptif hormonal, en raison de l'effet inducteur enzymatique du millepertuis, avec risque de baisse d'efficacité voire d'annulation de l'effet dont les conséquences peuvent être éventuellement graves (survenue d'une grossesse).	**CONTRE-INDICATION**
+ *ETOPOSIDE*		
	Risque de diminution des concentrations plasmatiques d'étoposide par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**
+ *FEXOFENADINE*		
	Diminution des concentrations plasmatiques de la féxofénadine par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**
+ *FOSTEMSAVIR*		
	Risque de diminution significative des concentrations de fostemsavir avec le millepertuis, avec réduction de la réponse virologique.	**CONTRE-INDICATION**
+ *GILTÉRITINIB*		
	Diminution des concentrations plasmatiques de gilteritinib avec risque de perte d'efficacité.	**CONTRE-INDICATION**
+ *GLÉCAPRÉVIR + PIBRENTASVIR*		
	Diminution des concentrations plasmatiques de la bithérapie par augmentation de son métabolisme par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**
+ *HORMONES THYROÏDIENNES*		
	Risque de baisse de l'efficacité des hormones thyroïdiennes.	**Association DECONSEILLEE**

+ *IDÉLALISIB*		
	Risque de diminution importante des concentrations plasmatiques d'idélalisib par augmentation de son métabolisme hépatique par le millepertuis.	**Association DECONSEILLEE**
+ *IMAO IRRÉVERSIBLES*		
	Risque d'apparition d'un syndrome sérotoninergique.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique régulière, notamment en début d'association.
+ *IMAO-A RÉVERSIBLES, Y COMPRIS OXAZOLIDINONES ET BLEU DE MÉTHYLÈNE*		
	Risque d'apparition d'un syndrome sérotoninergique.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique régulière, notamment en début d'association.
+ *IMMUNOSUPPRESSEURS*		
	Diminution des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur, en raison de l'effet inducteur enzymatique du millepertuis, avec risque de baisse d'efficacité voire d'annulation de l'effet dont les conséquences peuvent être éventuellement graves (rejet de greffe).	**CONTRE-INDICATION**
+ *INHIBITEURS DE LA 5-ALPHA REDUCTASE*		
	Diminution des concentrations plasmatiques de l'inhibiteur de la 5-alpha réductase par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**
+ *INHIBITEURS DE PROTÉASES BOOSTÉS PAR RITONAVIR*		
	Diminution des concentrations plasmatiques de l'inhibiteur de protéases, en raison de l'effet inducteur enzymatique du millepertuis, avec risque de baisse d'efficacité voire d'annulation de l'effet dont les conséquences peuvent être éventuellement graves (baisse de l'efficacité antirétrovirale).	**CONTRE-INDICATION** En cas d'association fortuite, ne pas interrompre brutalement la prise de millepertuis mais contrôler les concentrations plasmatiques (ou l'efficacité) de l'inhibiteur de protéases avant puis après l'arrêt du millepertuis.
+ *INHIBITEURS DE TYROSINE KINASES MÉTABOLISÉS*		
	Diminution des concentrations plasmatiques et de l'efficacité de l'inhibiteur de tyrosine kinase, par augmentation de son métabolisme par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**
+ *INHIBITEURS SÉLECTIFS DE LA RECAPTURE DE LA SÉROTONINE*		
	Risque d'apparition d'un syndrome sérotoninergique.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique régulière, notamment en début d'association.
+ *IRINOTECAN*		
	Diminution des concentrations plasmatiques du métabolite actif de l'irinotécan, avec risque d'échec du traitement cytotoxique.	**CONTRE-INDICATION**
+ *ISAVUCONAZOLE*		
	Diminution des concentrations plasmatiques d'isavuconazole par augmentation de son métabolisme hépatique par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**
+ *ITRACONAZOLE*		
	Risque de diminution importante des concentrations plasmatiques d'itraconazole, avec risque de perte d'efficacité, par augmentation de son métabolisme hépatique par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**
+ *IVABRADINE*		
	Risque de diminution de l'efficacité de l'ivabradine, par augmentation de son métabolisme par le millepertuis.	**Association DECONSEILLEE**
+ *LÉDIPASVIR*		
	Risque de diminution importante des concentrations plasmatiques du lédipasvir par augmentation de son métabolisme hépatique par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**
+ *LÉNACAPAVIR*		
	Diminution, éventuellement considérable, des concentrations de lénacapavir, avec risque de réduction de la réponse virologique.	**CONTRE-INDICATION**

+ LOMITAPIDE		
	Risque de diminution des concentrations plasmatiques du lomitapide.	**Association DECONSEILLEE**
+ LURASIDONE		
	Diminution des concentrations plasmatiques de la lurasidone par augmentation de son métabolisme hépatique par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**
+ MACITENTAN		
	Risque de diminution des concentrations plasmatiques de macitentan par augmentation de son métabolisme par le millepertuis.	**Association DECONSEILLEE**
+ MARAVIROC		
	Risque de diminution des concentrations plasmatiques de maraviroc pouvant conduire à une perte de la réponse virologique.	**Association DECONSEILLEE**
+ METHADONE		
	Diminution des concentrations de méthadone par le millepertuis, avec risque de syndrome de sevrage.	**CONTRE-INDICATION**
+ MIDAZOLAM		
	Risque de diminution des concentrations plasmatiques de midazolam par le millepertuis.	**A prendre en compte**
+ MIDOSTAURINE		
	Diminution des concentrations de midostaurine par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**
+ NEVIRAPINE		
	Risque de diminution significative des concentrations plasmatiques de la névirapine par augmentation de son métabolisme hépatique par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**
+ NINTÉDANIB		
	Diminution des concentrations plasmatiques du nintédanib par diminution de son absorption par le millepertuis.	**Association DECONSEILLEE**
+ OLAPARIB		
	Risque de diminution des concentrations plasmatiques d'olaparib et de son efficacité, par augmentation de son métabolisme par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**
+ OXYCODONE		
	Diminution des concentrations plasmatiques de l'oxycodone par augmentation de son métabolisme par le millepertuis.	**Association DECONSEILLEE** Adaptation éventuelle de la posologie de l'oxycodone .
+ PACLITAXEL		
	Risque de moindre efficacité du taxane par augmentation de son métabolisme par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**
+ PROGESTATIFS CONTRACEPTIFS		
	Diminution des concentrations plasmatiques du contraceptif hormonal, en raison de l'effet inducteur enzymatique du millepertuis, avec risque de baisse d'efficacité voire d'annulation de l'effet dont les conséquences peuvent être éventuellement graves (survenue d'une grossesse).	**CONTRE-INDICATION**
+ PROPAFENONE		
	Diminution des concentrations plasmatiques de la propafénone par augmentation de son métabolisme hépatique par le millepertuis.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et ECG. S'il y a lieu, adaptation de la posologie de la propafénone pendant l'association et après l'arrêt du millepertuis.

+ *QUETIAPINE*		
	Diminution très importante des concentrations plasmatiques de quétiapine par augmentation de son métabolisme hépatique par l'inducteur, avec risque d'inefficacité.	**Association DECONSEILLEE**
+ *RÉGORAFÉNIB*		
	Diminution des concentrations plasmatiques de régorafenib par augmentation de son métabolisme par le millepertuis	**Association DECONSEILLEE**
+ *RILPIVIRINE*		
	Risque de diminution des concentrations plasmatiques de rilpivirine par augmentation de son métabolisme hépatique par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**
+ *ROLAPITANT*		
	Diminution très importante des concentrations de rolapitant avec risque de perte d'efficacité.	**CONTRE-INDICATION**
+ *SIMVASTATINE*		
	Diminution de l'efficacité de l'hypocholestérolémiant par augmentation de son métabolisme hépatique par le millepertuis.	**Association DECONSEILLEE**
+ *SOFOSBUVIR*		
	Risque de diminution des concentrations plasmatiques de sofosbuvir par diminution de son absorption intestinale par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**
+ *TAMOXIFENE*		
	Risque d'inefficacité du tamoxifène par augmentation de son métabolisme par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**
+ *TELITHROMYCINE*		
	Diminution des concentrations plasmatiques de la télithromycine, avec risque d'échec du traitement anti-infectieux, par augmentation du métabolisme hépatique de la télithromycine par le millepertuis.	**Association DECONSEILLEE**
+ *THÉOPHYLLINE (ET, PAR EXTRAPOLATION, AMINOPHYLLINE)*		
	Diminution des concentrations plasmatiques de la théophylline, en raison de l'effet inducteur enzymatique du millepertuis, avec risque de baisse d'efficacité voire d'annulation de l'effet dont les conséquences peuvent être éventuellement graves (survenue d'un trouble ventilatoire obstructif).	**CONTRE-INDICATION** En cas d'association fortuite, ne pas interrompre brutalement la prise de millepertuis mais contrôler les concentrations plasmatiques (ou l'efficacité) du médicament associé avant puis après l'arrêt du millepertuis.
+ *TICAGRELOR*		
	Risque de diminution importante des concentrations plasmatiques de ticagrelor par augmentation de son métabolisme hépatique par le millepertuis, avec diminution de son effet thérapeutique.	**CONTRE-INDICATION**
+ *ULIPRISTAL*		
	Risque de diminution de l'effet de l'ulipristal, par augmentation de son métabolisme hépatique par l'inducteur.	**Association DECONSEILLEE** Préférer une alternative thérapeutique peu ou pas métabolisée.
+ *VELPATASVIR*		
	Diminution des concentrations plasmatiques de velpatasvir par le millepertuis, avec possible retentissement sur l'efficacité.	**CONTRE-INDICATION**
+ *VÉNÉTOCLAX*		
	Diminution importante des concentrations de vénétoclax, avec risque de perte d'efficacité.	**CONTRE-INDICATION**
+ *VERAPAMIL*		
	Réduction importante des concentrations de vérapamil, avec risque de perte de son effet thérapeutique.	**CONTRE-INDICATION**

+ *VINCA-ALCALOÏDES CYTOTOXIQUES*

	Risque de moindre efficacité du cytotoxique par augmentation de son métabolisme par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**

+ *VISMODÉGIB*

	Risque de diminution des concentrations plasmatiques de vismodégib.	**CONTRE-INDICATION**

+ *VORICONAZOLE*

	Réduction importante des concentrations de voriconazole, avec risque de perte de son effet thérapeutique.	**CONTRE-INDICATION**

MINÉRALOCORTICOÏDES

(desoxycortone, fludrocortisone)

+ *INDUCTEURS ENZYMATIQUES PUISSANTS*

	Diminution des concentrations plasmatiques et de l'efficacité des corticoïdes par augmentation de leur métabolisme hépatique par l'inducteur : les conséquences sont particulièrement importantes chez les addisoniens traités par l'hydrocortisone et en cas de transplantation.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique ; adaptation de la posologie des corticoïdes pendant le traitement par l'inducteur et après son arrêt.

+ *RIFAMPICINE*

	Diminution des concentrations plasmatiques et de l'efficacité des corticoïdes par augmentation de leur métabolisme hépatique par la rifampicine ; les conséquences sont particulièrement importantes chez les addisoniens traités par l'hydrocortisone et en cas de transplantation.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique ; adaptation de la posologie des corticoïdes pendant le traitement par la rifampicine et après son arrêt.

MIRABÉGRON

+ *METOPROLOL*

	Avec le métoprolol utilisé dans l'insuffisance cardiaque, augmentation des concentrations plasmatiques du métoprolol par diminution de son métabolisme par le mirabégron.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et réduction éventuelle de la posologie du métoprolol pendant l'association.

+ *PROPAFENONE*

	Augmentation des concentrations plasmatiques de la propafénone par diminution de son métabolisme par le mirabégron.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et réduction éventuelle de la posologie de la propafénone pendant l'association.

MITOMYCINE C

Voir aussi : cytotoxiques

+ *VINCA-ALCALOÏDES CYTOTOXIQUES*

	Risque de majoration de la toxicité pulmonaire de la mitomycine et des vinca-alcaloïdes.	**A prendre en compte**

MITOTANE

+ *DASABUVIR*

	Risque de diminution des concentrations plasmatiques du dasabuvir par le mitotane.	**CONTRE-INDICATION**

+ *FOSTEMSAVIR*

	Diminution significative des concentrations de fostemsavir avec la rifampicine, avec risque de réduction de la réponse virologique. Éventualité non exclue avec le mitotane.	**CONTRE-INDICATION**

+ *SPIRONOLACTONE*

	Possible réduction voire abolition de l'effet pharmacodynamique du mitotane par la spironolactone, associé à une baisse des concentrations du mitotane.	**CONTRE-INDICATION**

MOCLOBEMIDE

Voir aussi : IMAO-A réversibles, y compris oxazolidinones et bleu de méthylène - médicaments à l'origine d'un syndrome sérotoninergique

+ *CIMETIDINE*

	Avec la cimétidine utilisée à des doses supérieures ou égales à 800 mg/j : augmentation des concentrations du moclobémide, par diminution de son métabolisme hépatique.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique avec adaptation éventuelle de la posologie de moclobémide.

PACLITAXEL

Voir aussi : cytotoxiques - substrats à risque du CYP3A4

+ AMIODARONE

	Risque de majoration des effets indésirables du paclitaxel par diminution de son métabolisme hépatique par l'amiodarone.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et adaptation éventuelle de la posologie du paclitaxel.

+ CLOPIDOGREL

	Augmentation des concentrations du paclitaxel par le clopidogrel, avec risque de majoration des effets indésirables.	**A prendre en compte**

+ DEFERASIROX

	Risque d'augmentation des concentrations plasmatiques du paclitaxel par inhibition de son métabolisme hépatique par le deferasirox.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique étroite.

+ GEMFIBROZIL

	Risque d'augmentation des concentrations plasmatiques du paclitaxel par inhibition de son métabolisme hépatique par le gemfibrozil.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique étroite et adaptation de la posologie du paclitaxel pendant l'association.

+ INDUCTEURS ENZYMATIQUES

	Diminution des concentrations du cytotoxique par augmentation de son métabolisme par l'inducteur, avec risque de moindre efficacité.	**Association DECONSEILLEE**

+ MILLEPERTUIS

	Risque de moindre efficacité du taxane par augmentation de son métabolisme par le millepertuis.	**CONTRE-INDICATION**

+ TRIMETHOPRIME

	Risque d'augmentation des concentrations plasmatiques du paclitaxel par inhibition de son métabolisme hépatique par le triméthoprime.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique étroite et adaptation de la posologie du paclitaxel pendant l'association.

PAMPLEMOUSSE (JUS ET FRUIT)

Le jus de pamplemousse peut augmenter la biodisponibilité de quelques médicaments, notamment certains immunosuppresseurs (ciclosporine, tacrolimus, sirolimus), les dihydropyridines, certaines statines et le cisapride. Les conséquences cliniques de ces interactions sont variables et dépendent de nombreux facteurs comme la susceptibilité individuelle du patient, la nature ainsi que la quantité de jus de pamplemousse consommé, la simultanéité des prises, qui agit comme un facteur favorisant, et la marge thérapeutique du médicament associé. En conséquence, il est recommandé de déconseiller au patient la consommation de jus de pamplemousse en cas de traitements par ces médicaments, surtout s'il s'agit de simvastatine, dont les concentrations peuvent être considérablement augmentées.

(anpu

+ ATORVASTATINE

	Augmentation des concentrations plasmatiques de l'hypolipémiant, avec risque de survenue d'effets indésirables, notamment musculaires.	**A prendre en compte**

+ AVANAFIL

	Augmentation des concentrations plasmatiques de l'avanafil, avec risque d'hypotension.	**Association DECONSEILLEE**

+ BUSPIRONE

	Risque de majoration des effets indésirables de la buspirone par diminution de son métabolisme par le pamplemousse.	**A prendre en compte**

+ CARBAMAZEPINE

	Augmentation des concentrations plasmatiques de carbamazépine, avec risque de surdosage, par inhibition de son métabolisme par le pamplemousse.	**Association DECONSEILLEE**

+ DRONEDARONE

	Augmentation des concentrations de dronédarone par inhibition de son métabolisme par le pamplemousse.	**Association DECONSEILLEE**

+ HALOFANTRINE

	Risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointes.	**Association DECONSEILLEE**

+ *IMMUNOSUPPRESSEURS*		
	Augmentation de la biodisponibilité de l'immunosuppresseur et par conséquent de ses effets indésirables.	**Association DECONSEILLEE**
+ *IVABRADINE*		
	Augmentation des concentrations plasmatiques de l'ivabradine et de ses effets indésirables (inhibition de son métabolisme intestinal par le pamplemousse).	**Association DECONSEILLEE**
+ *IVACAFTOR (SEUL OU ASSOCIÉ)*		
	Risque d'augmentation des concentrations plasmatiques d'ivacaftor par le jus de pamplemousse.	**Association DECONSEILLEE**
+ *LERCANIDIPINE*		
	Risque majoré d'effets indésirables, notamment d'oedèmes, par diminution du métabolisme intestinal de la dihydropyridine.	**A prendre en compte**
+ *LURASIDONE*		
	Augmentation des concentrations plasmatiques de la lurasidone par diminution de son métabolisme par le pamplemousse.	**Association DECONSEILLEE**
+ *NALOXEGOL*		
	Risque d'augmentation des effets indésirables du naloxegol par le pamplemousse.	**Association DECONSEILLEE**
+ *OLAPARIB*		
	Risque d'augmentation des effets indésirables de l'olaparib.	**Association DECONSEILLEE**
+ *RÉGORAFÉNIB*		
	Augmentation des concentrations plasmatiques de régorafenib par diminution de son métabolisme hépatique par le pamplemousse.	**Association DECONSEILLEE**
+ *SERTRALINE*		
	Augmentation parfois importante des concentrations de l'antidépresseur chez certains patients par diminution de son métabolisme intestinal.	**Association DECONSEILLEE**
+ *SIMVASTATINE*		
	Augmentation considérable des concentrations plasmatiques de l'hypolipémiant, avec risque de survenue d'effets indésirables, notamment musculaires.	**Association DECONSEILLEE**
+ *TICAGRELOR*		
	Doublement des concentrations plasmatiques de l'antiagrégant, avec risque de majoration des effets indésirables, notamment hémorragiques.	**Association DECONSEILLEE**
+ *TOLVAPTAN*		
	Augmentation importante (entre 2 à 5 fois en moyenne) des concentrations de tolvaptan, avec risque de majoration importante des effets indésirables, notamment diurèse importante, déshydratation, insuffisance rénale aiguë.	**Association DECONSEILLEE**
+ *VARDENAFIL*		
	Augmentation des concentrations plasmatiques du vardénafil, avec risque d'hypotension.	**Association DECONSEILLEE**
+ *VÉNÉTOCLAX*		
	Augmentation des concentrations de vénétoclax, avec risque de majoration des effets indésirables.	**Association DECONSEILLEE**
+ *VERAPAMIL*		
	Augmentation des concentrations plasmatiques de vérapamil, avec risque de survenue d'effets indésirables.	**A prendre en compte**

PANOBINOSTAT

+ *INHIBITEURS PUISSANTS DU CYP3A4*

	Risque de majoration des effets indésirables, notamment cardiaques, du panobinostat par diminution de son métabolisme par l'inhibiteur.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et ECG. Débuter le traitement à dose réduite de moitié (10 mg).

PARACETAMOL

+ *ANTIVITAMINES K*

	Risque d'augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique en cas de prise de paracétamol aux doses maximales (4 g/j) pendant au moins 4 jours.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par le paracétamol et après son arrêt.

+ *FLUCLOXACILLINE*

	Risque accru d'acidose métabolique à trou anionique élevé, notamment en cas d'insuffisance rénale sévère, de sepsis, de facteurs prédisposant à la déplétion en glutathion (malnutrition, alcoolisme chronique…), ainsi qu'en cas d'utilisation de paracétamol aux doses quotidiennes maximales.	**Association DECONSEILLEE** Si l'association ne peut être évitée, surveillance étroite avec mesure de la 5-oxoproline urinaire.

PAROXETINE

Voir aussi : hyponatrémiants - inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine - médicaments abaissant le seuil épileptogène - médicaments à l'origine d'un syndrome sérotoninergique

+ *CARBAMAZEPINE*

	Augmentation des concentrations plasmatiques de carbamazépine avec signes de surdosage.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique, contrôle des concentrations plasmatiques de carbamazépine et réduction éventuelle de la posologie de la carbamazépine pendant le traitement par l'antidépresseur sérotoninergique et après son arrêt.

+ *CODEINE*

	Diminution de l'efficacité de l'opiacé par inhibition de son métabolisme par l'inhibiteur.	**Association DECONSEILLEE**

+ *MEQUITAZINE*

	Risque de majoration des effets indésirables de la méquitazine, par inhibition de son métabolisme par l'inhibiteur enzymatique.	**Association DECONSEILLEE**

+ *METOPROLOL*

	Risque de majoration des effets indésirables du métoprolol, avec notamment bradycardie excessive, par inhibition de son métabolisme par la paroxétine.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique accrue ; si besoin, adaptation de la posologie du métoprolol pendant la durée du traitement par la paroxétine et après son arrêt.

+ *NEBIVOLOL*

	Risque de majoration des effets indésirables du nébivolol avec notamment bradycardie excessive, par inhibition de son métabolisme par l'antidépresseur.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique accrue ; si besoin, adaptation de la posologie du nébivolol pendant la durée du traitement par l'antidépresseur et après son arrêt.

+ *PIMOZIDE*

	Risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointes.	**CONTRE-INDICATION**

+ *RISPERIDONE*

	Augmentation de la fraction active de la rispéridone par diminution de son métabolisme hépatique par la paroxétine, avec risque de majoration des effets indésirables.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et, si besoin, adaptation posologique de la rispéridone.

+ *TAMOXIFENE*

	Baisse de l'efficacité du tamoxifène, par inhibition de la formation de son métabolite actif par la paroxétine.	**Association DECONSEILLEE**

+ *TETRABENAZINE*

	Augmentation possiblement très importante de l'exposition des métabolites actifs de la tétrabénazine.	**CONTRE-INDICATION**

+ *TRAMADOL*

	Diminution de l'efficacité de l'opiacé par inhibition de son métabolisme par l'inhibiteur.	**Association DECONSEILLEE**

PRIMIDONE

Voir aussi : anticonvulsivants métabolisés - barbituriques - inducteurs enzymatiques - inducteurs enzymatiques puissants - médicaments sédatifs - phénobarbital (et, par extrapolation, primidone)

+ AFATINIB

	Diminution des concentrations plasmatiques de l'afatinib par augmentation de son métabolisme par la primidone.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique pendant l'association et 1 à 2 semaines après leur arrêt.

PRISTINAMYCINE

+ ANTIVITAMINES K

	Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique.	**Précaution d'emploi** Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'antivitamine K pendant le traitement par la pristinamycine et après son arrêt.

+ COLCHICINE

	Augmentation des effets indésirables de la colchicine aux conséquences potentiellement fatales.	**CONTRE-INDICATION**

+ IMMUNOSUPPRESSEURS

	Augmentation des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur par inhibition de son métabolisme hépatique.	**Précaution d'emploi** Dosage des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur, contrôle de la fonction rénale et adaptation de sa posologie pendant l'association et après son arrêt.

PROBENECIDE

+ ACIDE ACETYLSALICYLIQUE

	Diminution de l'effet uricosurique par compétition de l'élimination de l'acide urique au niveau des tubules rénaux.	**Association DECONSEILLEE**

+ DIPROPHYLLINE

	Risque de surdosage par augmentation des concentrations plasmatiques de diprophylline (inhibition de sa sécrétion tubulaire rénale).	**Précaution d'emploi** Réduire la posologie de diprophylline pendant le traitement par le probénécide.

+ METHOTREXATE

	Augmentation de la toxicité du méthotrexate : inhibition de la sécrétion tubulaire rénale du méthotrexate par le probénécide.	**CONTRE-INDICATION**

PROCARBAZINE

Voir aussi : antabuse (réaction) - cytotoxiques

+ INDUCTEURS ENZYMATIQUES PUISSANTS

	Augmentation des réactions d'hypersensibilité (hyperéosinophilie, rash), par augmentation du métabolisme de la procarbazine par l'inducteur.	**A prendre en compte**

PRODUITS DE CONTRASTE IODÉS

(acide amidotrizoïque, acide ioxaglique, acide ioxitalamique, iobitridol, iodixanol, iohexol, iomeprol, iopamidol, iopromide, ioversol)

+ ALDESLEUKINE

	Majoration du risque de réaction aux produits de contraste en cas de traitement antérieur par interleukine 2 : éruption cutanée ou plus rarement hypotension, oligurie voire insuffisance rénale.	**A prendre en compte**

+ DIURÉTIQUES

	En cas de déshydratation provoquée par les diurétiques, risque majoré d'insuffisance rénale fonctionnelle aiguë, en particulier lors d'utilisation de doses importantes de produits de contraste iodés.	**Précaution d'emploi** Réhydratation avant administration du produit iodé.

+ METFORMINE

	Risque important d'acidose lactique par hémoconcentration de la metformine, dans le cas d'un arrêt cardio-respiratoire induit par l'examen radiologique, avec insuffisance rénale aiguë.	**CONTRE-INDICATION** Le traitement par la metformine doit être suspendu au moment de l'examen radiologique pour n'être repris que 2 jours après.
	Risque important d'acidose lactique par hémoconcentration de la metformine, dans le cas d'un arrêt cardio-respiratoire induit par l'examen radiologique, avec insuffisance rénale aiguë.	**CONTRE-INDICATION** Le traitement par la metformine doit être suspendu au moment de l'examen radiologique pour n'être repris que 2 jours après.
	Risque important d'acidose lactique par hémoconcentration de la metformine, dans le cas d'un arrêt cardio-respiratoire induit par l'examen radiologique, avec insuffisance rénale aiguë.	**CONTRE-INDICATION** Le traitement par la metformine doit être suspendu au moment de l'examen radiologique pour n'être repris que 2 jours après.

SIMVASTATINE

Voir aussi : inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase (statines) - médicaments à l'origine d'atteintes musculaires - substrats à risque du CYP3A4

+ AMIODARONE

	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse (diminution du métabolisme hépatique de la simvastatine).	**Précaution d'emploi** Ne pas dépasser la posologie de 20 mg/j de simvastatine ou utiliser une autre statine non concernée par ce type d'interaction.

+ AMLODIPINE

	Risque majoré d'effets indésirables (dose-dépendants) à type de rhabdomyolyse (diminution du métabolisme hépatique de l'hypocholestérolémiant).	**Précaution d'emploi** Ne pas dépasser la posologie de 20 mg/j de simvastatine ou utiliser une autre statine non concernée par ce type d'interaction.

+ APALUTAMIDE

	Risque de diminution très importante des concentrations de la simvastatine, et perte d'efficacité, par augmentation de son métabolisme hépatique par l'apalutamide.	**Association DECONSEILLEE**

+ AZITHROMYCINE

	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse, par diminution du métabolisme hépatique de l'hypocholestérolémiant.	**Précaution d'emploi** Utiliser des doses plus faibles d'hypocholestérolémiant ou une autre statine non concernée par ce type d'interaction.

+ CARBAMAZEPINE

	Diminution importante des concentrations plasmatiques de simvastatine, par augmentation de son métabolisme hépatique.	**Association DECONSEILLEE**

+ CICLOSPORINE

	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse par diminution du métabolisme de la simvastatine.	**CONTRE-INDICATION**

+ DANAZOL

	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse par diminution du métabolisme de la simvastatine.	**CONTRE-INDICATION**

+ DILTIAZEM

	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse, par diminution du métabolisme hépatique de l'hypocholestérolémiant.	**Précaution d'emploi** Ne pas dépasser la posologie de 20 mg/jour de simvastatine. Si l'objectif thérapeutique n'est pas atteint à cette posologie, utiliser une autre statine non concernée par ce type d'interaction.

+ DRONEDARONE

	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse (diminution du métabolisme hépatique de la simvastatine).	**Association DECONSEILLEE**

+ FLUCONAZOLE

	Risque majoré d'effets indésirables concentration-dépendants à type de rhabdomyolyse (diminution du métabolisme hépatique de la simvastatine).	**Précaution d'emploi** Ne pas dépasser la posologie de 20 mg/j de simvastatine. Si l'objectif thérapeutique n'est pas atteint, utiliser une autre statine non concernée par ce type d'interaction.

+ GLÉCAPRÉVIR + PIBRENTASVIR

	Augmentation importante des concentrations plasmatiques de simvastatine par la bithérapie, avec risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyses .	**CONTRE-INDICATION**

+ INHIBITEURS PUISSANTS DU CYP3A4

	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse par diminution du métabolisme de la simvastatine.	**CONTRE-INDICATION**

+ MILLEPERTUIS

	Diminution de l'efficacité de l'hypocholestérolémiant par augmentation de son métabolisme hépatique par le millepertuis.	**Association DECONSEILLEE**

+ OMBITASVIR + PARITAPRÉVIR

	Augmentation des concentrations plasmatiques de la simvastatine par diminution de son métabolisme hépatique par la bithérapie.	**CONTRE-INDICATION**

+ *PAMPLEMOUSSE (JUS ET FRUIT)*		
	Augmentation considérable des concentrations plasmatiques de l'hypolipémiant, avec risque de survenue d'effets indésirables, notamment musculaires.	**Association DECONSEILLEE**
+ *PONATINIB*		
	Risque d'augmentation des concentrations plasmatiques de la simvastatine par augmentation de son absorption intestinale par le ponatinib.	**Précaution d'emploi** Surveillance clinique et biologique étroite pendant l'association.
+ *RANOLAZINE*		
	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse par inhibition du métabolisme de la simvastatine par la ranolazine.	**Précaution d'emploi** Ne pas dépasser la posologie de 20 mg/j de simvastatine ou utiliser une autre statine non concernée par ce type d'interaction.
+ *RIFAMPICINE*		
	Diminution très importante des concentrations plasmatiques de simvastatine, par augmentation de son métabolisme hépatique par la rifampicine.	**Association DECONSEILLEE**
+ *ROXITHROMYCINE*		
	Risque majoré d'effets indésirables (concentration-dépendants) à type de rhabdomyolyse.	**Précaution d'emploi** Utiliser des doses plus faibles d'hypocholestérolémiant.
+ *STIRIPENTOL*		
	Risque majoré d'effets indésirables (dose-dépendants) à type de rhabdomyolyse (diminution du métabolisme hépatique de l'hypocholestérolémiant).	**CONTRE-INDICATION**
+ *VERAPAMIL*		
	Risque majoré d'effets indésirables (dose-dépendants) à type de rhabdomyolyse (diminution du métabolisme hépatique de l'hypocholestérolémiant).	**Précaution d'emploi** Ne pas dépasser la posologie de 20 mg/j de simvastatine ou utiliser une autre statine non concernée par ce type d'interaction.

SIROLIMUS

Voir aussi : immunosuppresseurs - médicaments, bradykinine et angio-œdème - substrats à risque du CYP3A4

+ *CICLOSPORINE*		
	Augmentation des concentrations sanguines de sirolimus par la ciclosporine. La néphrotoxicité de la ciclosporine est également augmentée lors de l'association.	**Précaution d'emploi** Il est recommandé d'administrer le sirolimus 4 heures après la ciclosporine. Contrôle de la fonction rénale, pendant l'association et après son arrêt.
+ *INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION*		
	Majoration du risque d'angio-oedème.	**A prendre en compte**
+ *OMBITASVIR + PARITAPRÉVIR*		
	En association avec le ritonavir : augmentation significative des concentrations de l'immunosuppresseur avec risque de majoration de sa toxicité par la bithérapie.	**Association DECONSEILLEE** Si l'association s'avère nécessaire, contrôle strict de la fonction rénale, dosage des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur et adaptation éventuelle de la posologie.
+ *VERAPAMIL*		
	Augmentation des concentrations sanguines du sirolimus (diminution de son métabolisme hépatique par le vérapamil).	**Précaution d'emploi** Dosage des concentrations sanguines de l'immunosuppresseur, contrôle de la fonction rénale et adaptation de la posologie pendant l'association et après son arrêt.

SODIUM (BICARBONATE DE)

Voir aussi : alcalinisants urinaires

+ *LITHIUM*		
	Risque de baisse de l'efficacité du lithium par augmentation de son élimination rénale par les sels de sodium.	**Précaution d'emploi** Eviter les surcharges sodées et tenir compte de la présence de sodium dans certains médicaments comme les antiacides.

SODIUM (CHLORURE DE)

+ *LITHIUM*		
	Risque de baisse de l'efficacité du lithium par augmentation de son élimination rénale par les sels de sodium.	**Précaution d'emploi** Eviter les surcharges sodées et tenir compte de la présence de sodium dans certains médicaments comme les antiacides.